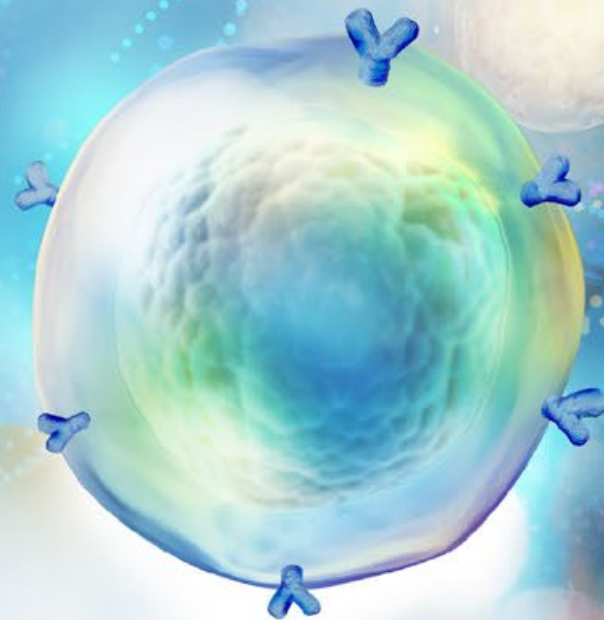




分析师大会演示材料

驯鹿生物

2025年12月



免责声明

This presentation has been prepared by Nanjing IASO Biotechnology Co., Ltd. (the “Company” or “us”) for a limited number of recipients solely for use at this presentation to research analysts and for information purposes only and not for public dissemination. You must hold this document and any oral information provided in connection with this presentation in strict confidence and may not communicate, reproduce, distribute or disclose it to any other person (whether within or outside your organization/firm), or refer to it publicly, in whole or in part at any time except with our prior written consent. The document is not prepared by Morgan Stanley Asia Limited and CCB International Capital Limited (the “Joint Sponsors”), nor any of its affiliates, controlling persons, directors, officers, partners, employees, agents, advisors or representatives. The use of registered trademarks, commercial trademarks and logos or photographic materials in this presentation are exclusively for illustrative purposes and are not meant to violate the rights of the creators and/or applicable intellectual property laws.

By attending this meeting or receiving this presentation, you shall be deemed to have agreed and undertaken that you (i) have read and will comply with the contents of this notice, (ii) will maintain absolute confidentiality regarding this presentation and the information disclosed in this document, (iii) have not obtained and will not seek from the Company or its advisers, whether directly or indirectly, any material information, including forward looking information, whether qualitative or quantitative, concerning the Company that is not reasonably expected to be included in the prospectus or publicly available, (iv) have read, and agreed to, the restrictions and observations set out in the guidelines (the “Research Report Guidelines”) dated [November [*]], 2025 titled “Project Cure – Syndicate Analysts’ Research Report Guidelines” from Paul Hastings and are deemed to have agreed to and represented to the Joint Sponsors the matters set out in the Research Report Guidelines, (v) will be solely responsible for your own assessment of the market and the market position of the Company and that you have conducted and will conduct your own analysis and be solely responsible for forming your own view of the potential future performance of the business of the Company, and (vi) you undertake to treat and handle this document with the strictest confidence, and shall indemnify and keep indemnified the Company and the Joint Sponsors and their respective affiliates, controlling persons, directors, officers, partners, employees, agents, advisors and representatives against all losses, damages, expenses and costs that any of them may sustain or incur as a result, whether directly or indirectly, of any breach of any provision in this disclaimer by you.

The information in this document has not been independently verified. The contents of this document have not been reviewed by any regulatory authority in any jurisdiction. This document does not purport to provide a complete description of the matters to which it relates. No reliance shall be made in relation to the information contained in this document. Some of the information contained in this presentation is still in draft form and may not be finalized until the time of publication of the Company’s prospectus and international offering circular relating to the proposed global offering. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is or will be made in, or in relation to, and no responsibility or liability (including, without limitation, any liability in negligence) is or will be accepted by us, the Joint Sponsors or our or its affiliates, or our or its officers, employees or agents, as to, or in relation to, this document or the accuracy, fairness, reasonableness, correctness, or completeness of the information contained herein or any other information, whether written or oral, made available to you or your advisers and any liability therefore is hereby expressly disclaimed. In particular, the slides forming part of this presentation have been prepared for the purposes of providing background information about the Company. Certain statements set forth in this document with respect to the Company or other events, including but not limited to opinions and forward-looking statements with respect to the future financial condition and results of operations of the Company and certain plans and objects of the management of the Company, are based on a number of assumptions, including but not limited to the present business strategies of the Company and other matters beyond the control of the Company, such as the political, social, legal and economic environment in which the Company will operate in the future. Such statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual performance or results of operations of the Company to differ materially from such opinions or forward-looking statements or the views, expressed or implied, contained in this document. None of the Company, the Joint Sponsors, nor any of its respective affiliates, advisors or representatives shall be obliged in any way to update such opinions or forward-looking statements for any event or circumstances that may occur. No representation or warranty is given as to the achievement or reasonableness of, and no reliance should be placed on, any forward-looking statements, assumptions, projections, targets, estimates or forecasts contained in this document. In all cases, you should conduct your own investigation and analysis of the Company and the data regarding the global economy and healthcare market and industry contained in this document. None of us, the Joint Sponsors or our or its affiliates, or our or its officers, employees or agents undertakes any obligation to provide the recipient with access to any additional information or to update this presentation or any additional information or to correct any inaccuracies in any such information which may become apparent.

This document does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer or an invitation to sell or issue or a solicitation of an offer to purchase or subscribe any securities nor shall there be any sale of such securities in any state, country or jurisdiction, in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state, country or jurisdiction. No securities of the Company have been, or will be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the “US Securities Act”) or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to a registered offering in compliance with or pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act and the applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. There will be no public offer of the Company’s securities in the United States.

This document and the information contained herein as well as information presented orally or otherwise are strictly confidential and must be treated as such. No part of this document or its contents may be copied or reproduced, or redistributed or passed on, directly or indirectly, to any other person in any manner or published, in whole or in part, for any other purpose. By accessing this document, you are deemed to represent to the Company and the Joint Sponsors and its respective affiliates, controlling persons, directors, offices, partners, employees, agents, representatives or advisers that you are, and any customers you represent are, either (i) a person outside the United States within the meaning of Regulation S under the U.S. Securities Act; or (ii) a qualified institutional buyer as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act. You also represent that you are, and any customers you represent are “professional investors” described in Part I of Schedule 1 to the Securities and Futures Ordinance and any subsidiary legislation thereunder (including but not limited to the Securities and Futures (Professional Investor) Rules (Chapter 571D of the Laws of Hong Kong)). To the extent you purchase the shares of the Company, you will be doing so pursuant to either Rule 144A or Regulation S or another exemption from registration under the U.S. Securities Act. Neither this document nor any copy of it may be taken or transmitted into or distributed, directly or indirectly, in the United States. Neither this document nor any copy of it may be taken or transmitted into Canada or distributed or redistributed in Japan or to any resident thereof. Upon request, the recipient will promptly return this document and all information made available, without retaining any copies.

In Hong Kong, no securities of the Company may be offered to the public unless a prospectus in connection with the offering for sale or subscription of such securities has been authorized by The Stock Exchange of Hong Kong Limited for registration by the Registrar of Companies in Hong Kong under the provisions of the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Cap.32 of the Laws of Hong Kong) (the “Companies Ordinance”), and has been so registered. This document contains no information or material which may result in it being deemed (1) to be a prospectus within the meaning of section 2(1) of Companies Ordinance, or an advertisement in relation to a prospectus or proposed prospectus or extract from or abridged version of a prospectus within the meaning of section 38B of the Companies Ordinance or an advertisement, invitation or document containing an advertisement or invitation falling within the meaning of section 103 of the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong) or (2) in Hong Kong to have effected an offer to the public without compliance with the laws of Hong Kong or being able to invoke any exemption available under the laws of Hong Kong, and is subject to material change without notice. No part of this document shall form the basis of or be relied upon in connection with any contract, commitment or investment decision in relation there to. The recipients and readers of this document should not construe the contents of this document as legal, tax, accounting or investment advice and should consult their own financial, tax, accounting or legal advisers or other consultants in case of doubt.

The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law, and the recipients into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe such restrictions. Neither this document nor any copy of it may be taken or transmitted into United States, Japan or Canada or distributed or redistributed in Japan or to any resident thereof. Upon request, the recipient will promptly return this document and all information made available to you, without retaining any copies.

You hereby accept the foregoing by attending this meeting or accepting delivery of the information contained herein. If you do not accept these conditions and give the acknowledgements and representations set out above, please immediately return this document to the Company. Any breach of the foregoing may constitute a breach of securities laws.

交易概要

发行人	• 南京驯鹿生物技术股份有限公司 (Nanjing IASO Biotechnology Co., Ltd.)
上市地	• 香港联交所主板（第18A章）
发行结构	• 国际配售 (144A / Reg S): 90% • 香港公开发售: 10%
募集资金用途	• 45%用于核心产品eque-cel的研发及商业化 • 35%用于开发其他产品及技术平台 • 10%用于产能扩张及流程优化项目 • 10%用于营运资金及其他一般公司用途
联席保荐人、整体协调人、 联席全球协调人、联席账簿 管理人及联席牵头经办人	Morgan Stanley 摩根士丹利  建银国际 CCB International

研究时间表

分析师路演	2025年12月15日
研究报告初稿	2026年2月末
研究报告终稿	2026年4月中旬
聆讯	2026年5月上旬
PHIP公布日	2026年5月上旬
研究报告发布日	2026年5月中旬
Blackout期间开始	2026年5月中旬

研究指引

Research reports should comply with the following general principles

- the report must be, and should present itself as, an independent outsider's view of the Company which has been independently produced and has not been verified or authorised by the Company or any syndicate members acting as underwriters of the Offering;
- the source of the information should be made clear. In particular, where statements are matters of opinion or conjecture of the authors this should be brought out, and there must be a reasonable basis for such statements;
- to the extent that statements and their implications can be substantiated against appropriate independent third party sources, this should be done by way of references and/or footnotes to such sources. To the extent that they cannot be substantiated, this should be made clear. Statements should not be misleading by omission, and must, to the best of the author's knowledge, be true, accurate, complete and fair;
- to the extent that information is based on published or historical information, and particularly if this information has not been updated, this should be made clear;
- it should be made clear that the research report does not, and does not attempt to contain everything material relating to the Company, and the report must not appear to be a definitive description of the Company, its financial condition or its prospects;
- the report should not discuss nor make reference to the Offering;
- a firm that has an investment banking relationship with the Company (including involvement in an initial public offering as a sponsor, or otherwise acting as a corporate finance adviser, or as an underwriter) is required to disclose that fact as a disclaimer in the research report under the requirements of the SFC. The disclaimer should state clearly (i) the nature of the bank's relationship with the Company and the specific role(s) being undertaken or contemplated (e.g., sponsor, underwriter, manager, co-manager, lead manager, etc.) and (ii) whether the firm or its affiliate(s) has been appointed or is seeking to be appointed. It is not sufficient simply to state that a firm "may be appointed";
- the report should not contain any material information, including forward looking information (whether qualitative or quantitative) concerning the Company save for projections and forecasts complying with paragraphs 14 and 15 below, that is not reasonably expected to be included in the prospectus or publicly available (or is derived from such information). In addition, the author of any research report must observe the restrictions imposed by the SFC on seeking to obtain from the Company or its directors, substantial shareholders, employees, or any of their respective advisers any such information;
- because research reports are not an offer to sell or an invitation to buy securities, and to reduce the risk of any such characterisation, research reports must not contain any "buy", "sell" or other recommendation with respect to, or price targets for, the securities covered by the Offering;
- during the preparation of research reports, Syndicate Analysts must comply with all applicable legal and regulatory requirements, including but not limited to paragraph 16 of the Code of Conduct in connection with the content and issue of the research reports;
- research reports should be precisely dated;
- it should be made clear that the research report should not be relied upon as representations of the Company, the Joint Global Coordinators or syndicate members in connection with the Offering. No opinions or estimates should be attributed to the Company, the Joint Global Coordinators or any of their respective officers or employees in a research report. All opinions and estimates must be those of the relevant Syndicate Analysts and stated as such; and
- research reports should include disclosure of (i) whether the syndicate member or any affiliate owns a significant stake in the Company, (ii) whether any employee of the syndicate member or any affiliate has a seat on the board of the Company, (iii) whether the syndicate member is doing, or is seeking to do business with the Company, and (iv) the basis of analyst compensation received.



张金华

创始人、董事长
兼首席执行官



张永克博士

首席科学官兼高级副总裁



张华

首席商务官兼高级副总裁



陈杰博士

首席医学官兼高级副总裁



张昕宇

高级副总裁兼财务负责人

章节 1	公司概况	8
章节 2	国际化和商业化	22
章节 3	产品管线介绍	26
章节 4	生产能力	38
章节 5	财务概览	40
章节 6	募集资金用途	44
章节 7	总结	46
附录 A	财务报表	49
附录 B	股权结构	57
附录 C	市场数据	59
附录 D	临床数据	63
附录 E	潜在里程碑	65

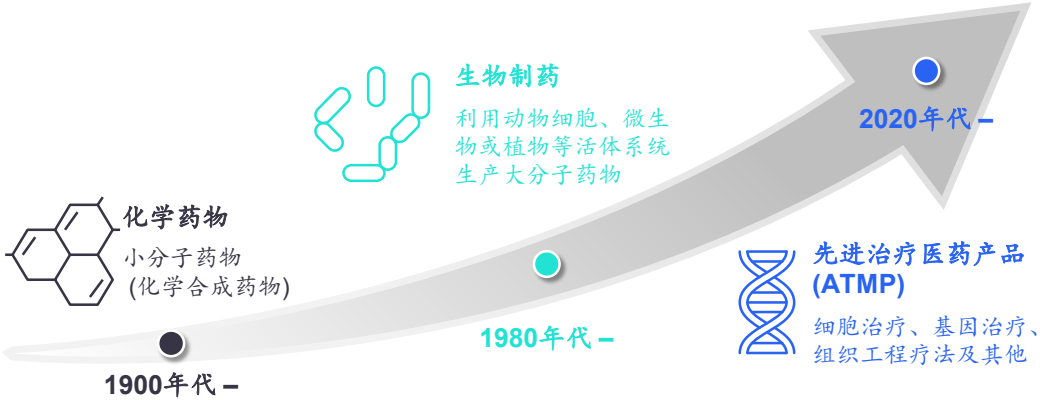
The background is a vibrant, abstract composition. It features several glowing DNA double helix structures in shades of blue, green, and yellow, scattered across the frame. Interspersed among these are various sized, semi-transparent spheres that appear to be made of a liquid or gel-like material, some with internal patterns. The overall color palette is dominated by cool blues and greens, with warm yellow and orange highlights from the glowing elements.

章节 1

公司概况

ATMP及CGT定义及市场情况

ATMP已成为全球生物科技战略的核心焦点，CGT为其中最重要之板块



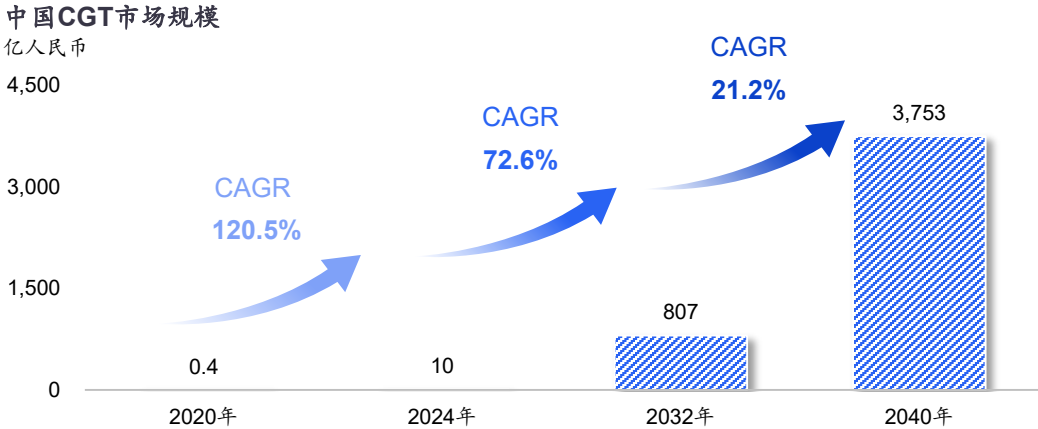
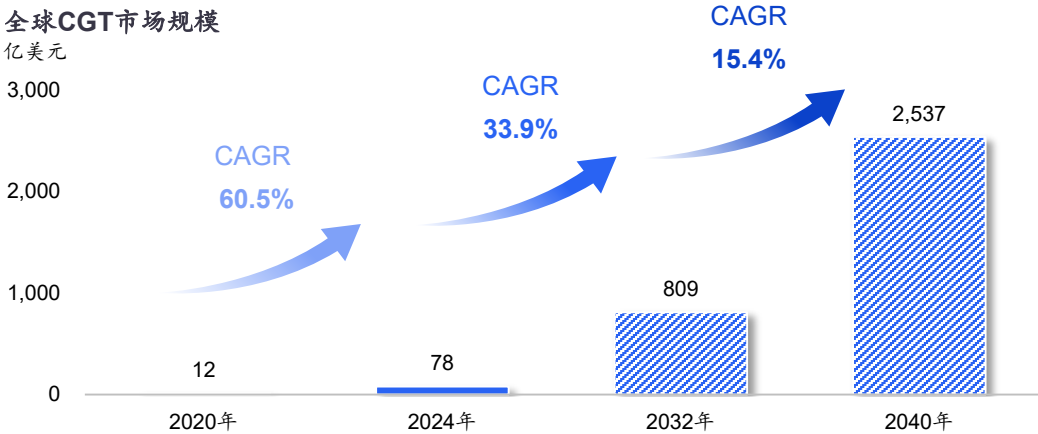
有别于传统的小分子药物与其他生物制剂主要通过调节疾病途径或纾缓症状，ATMP旨在针对疾病根源，通过再生细胞或组织、修复基因缺陷，从而达致功能性治愈



- ATMP为先进治疗药物，包括**细胞治疗**、**基因治疗**及**组织工程产品**
- 中国在ATMP开发方面已跻身全球领先地位，截至2024年，已登记的临床试验（涵盖CAR-T、干细胞及其他体细胞疗法）超过**1,300项**



- CGT为**细胞和基因疗法**，是ATMP领域中最重要之板块，包括：
 - **细胞基础疗法**（如**CAR-T细胞疗法**）
 - 针对由潜在的基因原因所造成之疾病的基因治疗，透过使用病毒或非病毒载体以基因添加、基因沉默或基因编辑方式修改基因
- 美国FDA已批准**七项**CAR-T细胞疗法，NMPA已批准**八项**



资料来源：弗若斯特沙利文

我们的理念和愿景

专注于创新生物疗法
为患者带来治愈希望

致力于为血液恶性肿瘤和自身免疫性疾病
带来崭新的治愈性疗法



600+
患者

核心产品Eque-cel (CT103A) 久经验证的出色表现

全球**首个**获批全人源CAR-T疗法及中国**首个**获批BCMA靶向CAR-T细胞疗法
安全性和有效性已在临床试验及真实世界研究超过**600**名患者身上得到广泛验证
ORR达**98.9%**, CR/sCR率达**88.4%**, MRD阴性率高达**98.9%**⁽¹⁾

10

产品, 核心产品
已纳入创新
商保目录

多元化、全面及均衡的产品管线

1种商业化核心产品, 和下一代*in vivo* CAR-T资产在目标患者群体方面互补
3项核心产品BLA申请已在大中华区获批⁽²⁾, **3**项申请在亚洲和中东地区已获受理或已提交
9种在研产品: **3**种*ex vivo* CAR-T疗法、**5**种*in vivo* CAR-T细胞疗法以及**1**种抗体产品

5

多样化平台

独特的技术平台



全人源抗体发现平台



高通量CAR-T疗法
筛选与优化平台



In vivo CAR-T
平台



临床开发与临床
转化研究平台



先进制造及
CMC平台

70%
市场份额

中国最全面的ATMP商业化平台之一

覆盖全国**100**多间领先医院及超过**95**家DTP药房; 中国MM CAR-T市场份额近**70%**
通过患者转诊、医疗旅游、NPP计划, 实现**海外患者来华或跨境接受治疗**
与知名生物制药企业建立合作: **Innovent** **Sana** **Cabaletta Bio** **Umoja**

注:

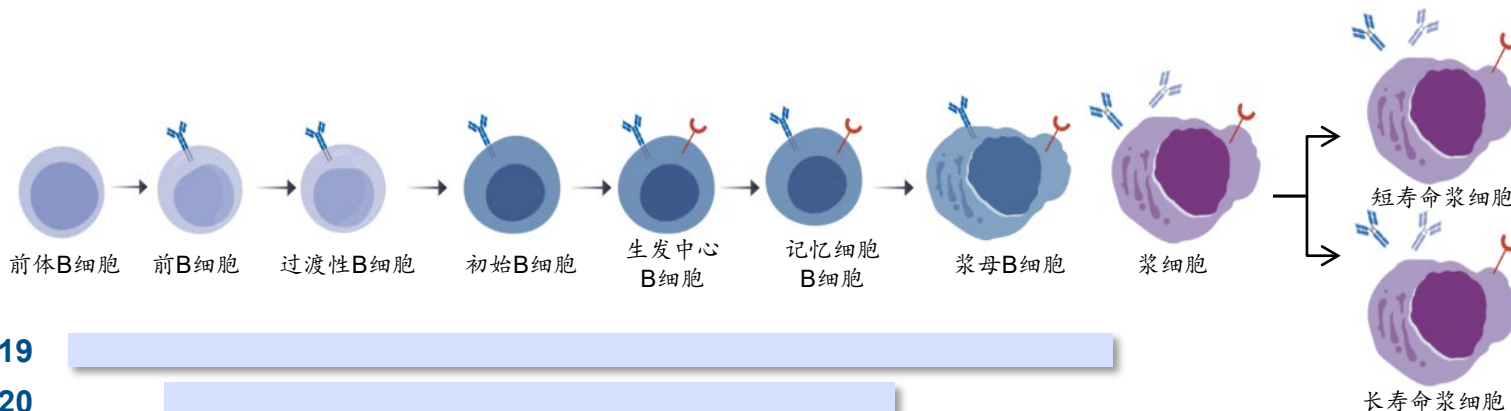
1. 数据来源: Ib/II 期关键试验 (于未接受CAR-T治疗的患者)。ORR: 客观缓解率; CR: 安全缓解; sCR: 严格完全缓解; MRD: 可微小残留病灶。
2. 根据公司官网信息, 公司核心产品已于2025年11月27日获中国香港卫生署批准上市, 用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤。

整合端到端开发能力，覆盖创新药物研发全周期及CMC及临床开发



专注于B细胞靶向疗法及其应用

B细胞成熟发育过程及关键靶点



CD19
CD20
CD22
BCMA
GPRC5D

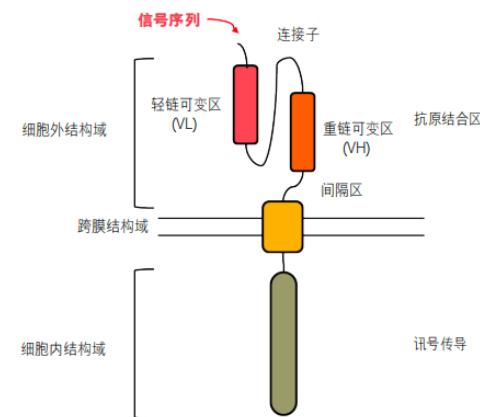
血液肿瘤

B细胞相关靶点已成为血液肿瘤的重要治疗切入点，在治疗白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤等疾病中展现重要疗效

自身免疫疾病

B细胞透过自身抗体生成、抗原呈递及细胞因子分泌参与自体免疫，相关靶点为自身免疫疾病治疗提供契机

CAR-T细胞疗法



- ✓ 由体内扩增、持续存活能力的活细胞组成
- ✓ 透过单次输注可实现深层持久疗效
- ✓ 持续监测及清除目标细胞
- ✓ 不受MHC限制，有效杀伤逃避免疫监控肿瘤细胞

CAR-T细胞疗法最初为血液系统恶性肿瘤所开发，已在自身免疫疾病中展现出强大潜力

B细胞相关靶点CAR-T细胞疗法已在血液瘤治疗取得前所未有疗效，并正在崛起成为治疗自身免疫疾病有效的新兴治疗方式

产品管线图



我们秉持前瞻性的视野，采用去风险化的策略，构建了多元、全面且均衡的产品管线

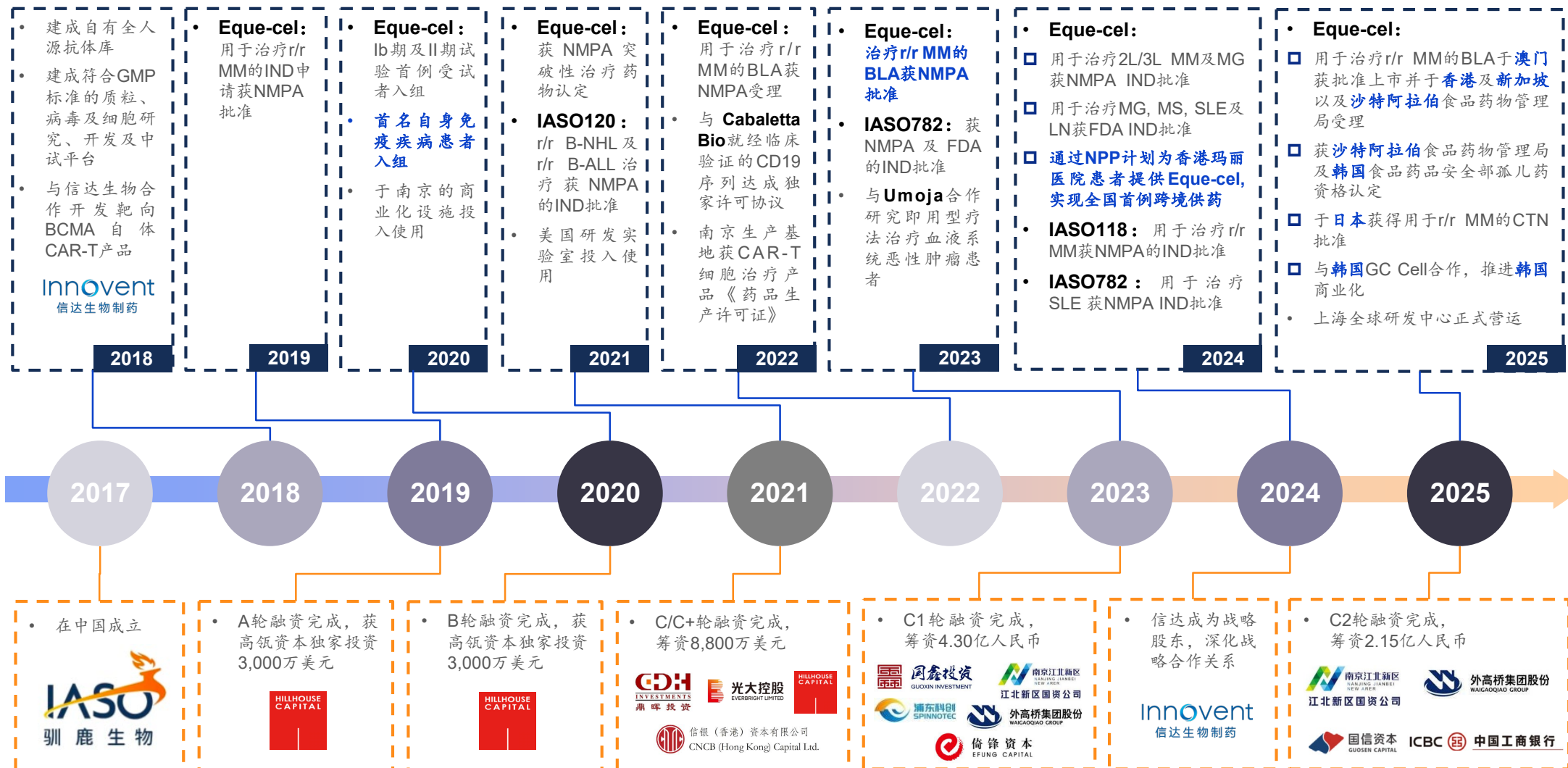
		项目 ⁽¹⁾	靶点	适应症 ⁽²⁾ (治疗方案) ⁽³⁾	临床前	I期	II期 / III期	BLA	目前状态 / 预计下一个里程碑	商业权利
细胞疗法	ex vivo CAR-T									
	Eque-cel (CT103A)★	BCMA	r/r MM (≥4L)	BLA 批准					2023年6月获NMPA及2025年3月获澳门特别行政区药物监督管理局批准BLA	全球 ⁽⁴⁾
				BLA申请已获受理或已提交					2025年1月获新加坡HSA受理BLA, 2025年2月获香港DOH受理BLA, 2025年7月获沙特阿拉伯SFDA受理BLA,以及2025年9月向阿联酋EDE提交BLA档案	
				IND (日本)					2025年10月收到IND批准	
			r/r MM (2L/3L)	III期注册试验					2026年下半年完成III期患者入组	
			NDMM (高危1L)	IIT					2025年第四季完成IIT	
			MG	IND					预期2026年上半年开始I期患者入组	
				IND (美国)					预期2026年上半年开始I期患者入组	
			MS/SLE/IIM等	IIT					2025年第四季完成IIT患者入组	
			MS	IND (美国)					预期2026年下半年开始I期患者入组	
			SLE/LN	IND (美国)					预期2027年开始I期患者入组	
	IASO120 ⁽⁵⁾	CD19/CD22	r/r B-NHL (≥3L)	II期注册试验					预期2026年下半年开始II期患者入组	
	IASO118 ⁽⁵⁾	GPRC5D	r/r MM (≥4L)	IND					预期2026年下半年开始I期患者入组	
	IASO140 ⁽⁵⁾	BCMA/GPRC5D	r/r MM (≥4L)	IIT					预期2025年第四季完成IIT患者入组	
	in vivo CAR-T									
IASO206	BCMA	r/r MM (≥4L)	IIT					预期2026年上半年开始IIT患者入组 预期2027年上半年向美国FDA及NMPA提交IND申请	全球	
IASO207	CD19	B-NHL (≥3L) 及 SLE	IIT					预期2025年第四季开始IIT患者入组 预期2026年下半年向美国FDA及NMPA提交IND申请		
IASO208	CD20	B-NHL (≥3L)	IIT					预期2025年第四季开始IIT患者入组 预期2026年下半年向美国FDA及NMPA提交IND申请		
IASO209	未披露	未披露	临床前					开发中		
IASO210	未披露	未披露	临床前					开发中		
抗体										
IASO782	CD19	ITP 及 wAIHA	I期临床试验					预期2026年下半年完成Ia期患者入组	全球	
			IND (美国)					2023年6月美国FDA批准IND		
			SLE	IND						预期2027年上半年开始Ib期患者入组

缩写: BCMA = B细胞成熟抗原; B-NHL=B细胞非霍奇金淋巴瘤; CAR-T=嵌合抗原受体T细胞; Eque-cel=伊基奥仑塞; IIM=特发性炎症性肌病; in vivo=活体内; ITP=免疫性血小板减少症; LN=狼疮性肾炎; MG=重症肌无力; MS=多发性硬化症; r/r MM=复发或难治性多发性骨髓瘤; NDMM=新诊断多发性骨髓瘤; SLE=系统性红斑狼疮; HM=血液系统恶性肿瘤; AD=自身免疫疾病; wAIHA=温抗体型自身免疫性溶血性贫血; BLA=生物制品许可证申请; 美国FDA=美国食品药品监督管理局; IIT=研究者发起的试验; IND=研究性新药申请; NCT=国家临床试验; NMPA=中国国家药品监督管理局

★ 核心产品 🌟 商业化产品 🌿 孤儿药资格认定 📐 根据在中国进行的临床试验, 获得监管机构豁免

注:
1. 除另有说明者外, 临床试验均在中国进行。
2. 该产品/在研产品旨在用作单一疗法。
3. 治疗指南并未按照治疗线对自身免疫疾病的治疗方法分类。业界惯例是依据疾病亚型、活动/严重程度及关键既往暴露类别来界定患者群体。
4. Eque-cel已在沙特阿拉伯和韩国获得治疗r/r MM的孤儿药资格认定。
5. IASO120、IASO118及IASO140分别原称为RD120、RD118及RD140。

公司发展历程



管理团队简介

由世界级专家、行业资深人士及资深创业者组成的远见卓识管理团队



张金华

创始人、执行董事、董事会主席兼首席执行官

- 曾任职于投资银行和领先的证券律师事务所，期间带领多间中国公司的国内外上市和并购重组项目
- 深厚的首次公开发售、并购以及生物医药领域的投资经历，曾以**天使投资人身份投资细胞疗法初创公司**，并担任董事
- 中国东北财经大学**法学学士学位及法学硕士学位**，均主修经济法



张永克博士
首席科学官兼
高级副总裁



胡广博士
研发副总裁



张华
首席商务官兼
高级副总裁



任春莉博士
注册高级副总裁



陈杰博士
首席医学官兼
高级副总裁



张昕宇
高级副总裁兼
财务负责人





推进Eque-cel的全球临床开发及注册，进一步释放核心产品的临床及商业价值



以前瞻性视角构建我们的下一代管线，增强我们的竞争地位



扩大在中国境内市场的商业足迹，强化我们的行业领导地位



实施「产品出、患者进」的全球策略，以推动可持续增长并扩大可及性



进一步提升我们的药物研发及制造能力



在全球范围探索战略投资及并购机会

中美联动，研发协同攻关

实现从早期开发到全球临床推进的高效衔接

- 我们执行一项严谨的全球扩张策略，在中国和美国建立研发中心，并在10多个地区探索临床和监管途径
- 2021年，我们的美国研发实验室投入使用；2025年，我们的上海全球研发中心正式投入营运



从研发到商业化的全球化战略



中美研发中心

- 已建立美国研发中心、南京研发基地、上海全球研发中心
- 中国在CAR-T创新领域的全球领先地位

- ✓ 中国在CAR-T领域已建立有利环境，IIT数据可用于支持IND申请，实现早期、低成本的临床探索，加速从研究到注册的过程
- ✓ NMPA和CDE为CGT提供加速监管途径，例如优先审查、附条件批准和突破性疗法认定，进一步缩短研发周期并促进商业化



推进国际化注册

采用直接注册与桥接及多中心研究相结合的国际注册策略：



直接注册：澳门、香港、新加坡、沙特阿拉伯、阿联酋、马来西亚及韩国

桥接及多中心研究：日本、巴西



全球商业化合作

「产品出、患者进」的全球策略

- 多层次的全球治疗平台：通过NPP和患者转诊计划促进早期国际准入
- 加强BD合作和许可活动：共同开发、License-in、License-out
- 全球一体化、创新驱动型细胞治疗供应商：透过涵盖工艺开发、技术转移和GMP生产支持的全面、可出口合作模式将整合平台变现

推进核心产品临床开发及注册，并打造下一代创新产品管线

推进Eque-cel的全球临床开发及注册，进一步释放临床及商业价值



临床开发

r/r MM

- ✓ 正在中国内地进行Eque-cel作为r/r MM二线或三线治疗的III期临床试验
- ✓ 预计于2028年提交BLA申请

自身免疫疾病

- ✓ 正在推进Eque-cel用于治疗MG及MS等自身免疫疾病的临床开发
 - 已在中国获得治疗MG的IND许可，并在2024年取得IND批准
 - 其他多种自身免疫疾病（包括MS、SLE及IIM）的临床开发目前处于IIT阶段



国际市场注册

采用**直接注册与桥接及多中心研究**相结合的国际注册策略

- 直接注册：澳门、香港、新加坡、沙特阿拉伯、阿联酋、马来西亚及韩国
- 桥接及多中心研究：日本及巴西

以前瞻性视角构建下一代管线，增强我们的竞争地位

双特异性细胞疗法

- ✓ **IASO120**：于2021年11月针对启动r/r B-ALL及r/r B-NHL的I/II期临床试验
- ✓ **IASO140**：利用FAST CAR-T平台并通过IIT推进研发

体内CAR-T

- ✓ **IASO208、IASO207及IASO206**：正在开展IIT，目标在2026H2至2027H1在美国及中国提交IND申请
- ✓ **其他体内CAR-T**：目前处于临床前阶段

抗体药物

- ✓ **IASO782**：正在中国进行用于治疗ITP及wAIHA的I期临床试验，并已在美国获得IND批准。正在启动治疗SLE的I期临床试验，预计2027H1开始招募患者

其他ATMP药物及探索方向

高治疗潜力靶点

BCMA CAR增强剂

抗衰老等治疗领域

深耕中国市场，拓展全球策略，同时探索战略投资及并购机会

扩大在中国境内市场的商业足迹

商业化策略

提升品牌知名度

扩大市场团队

加强区域覆盖

强化全产业链整合能力

与医院建立深度合作

促进KOL间的交流

创新支付模式

✓ 提高产品的保险覆盖，并加强市场推广力度

继续扩大国内惠民保险、商业保险、分期付款等覆盖范围

实施「产品出、患者进」的全球策略

全球策略

为把握CAR-T细胞疗法的庞大全球潜力，我们计划执行国际化策略，为全球市场扩张奠定基础

透过NPP和患者转诊计划促进早期国际准入

国际化的适应症拓展策略

共同开发、对外许可和引进许可

将现有技术转化为可复制的国际化服务平台

在全球范围探索战略投资及并购机会

技术能力

具备先进治疗药品开发能力及前沿技术的公司

产业协同

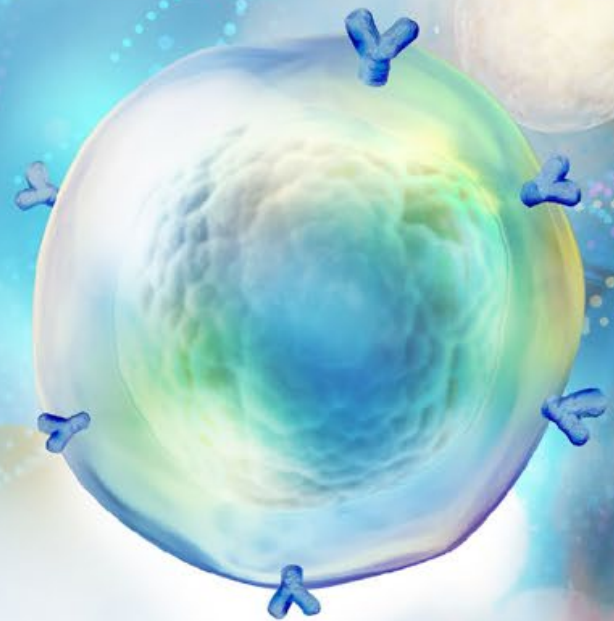
在产品、管线及产业链方面具有协同效应，有助于我们拓展治疗领域的公司

市场推广

有全面市场覆盖，有助于我们扩大商业足迹并推动全球扩张的公司

章节 2

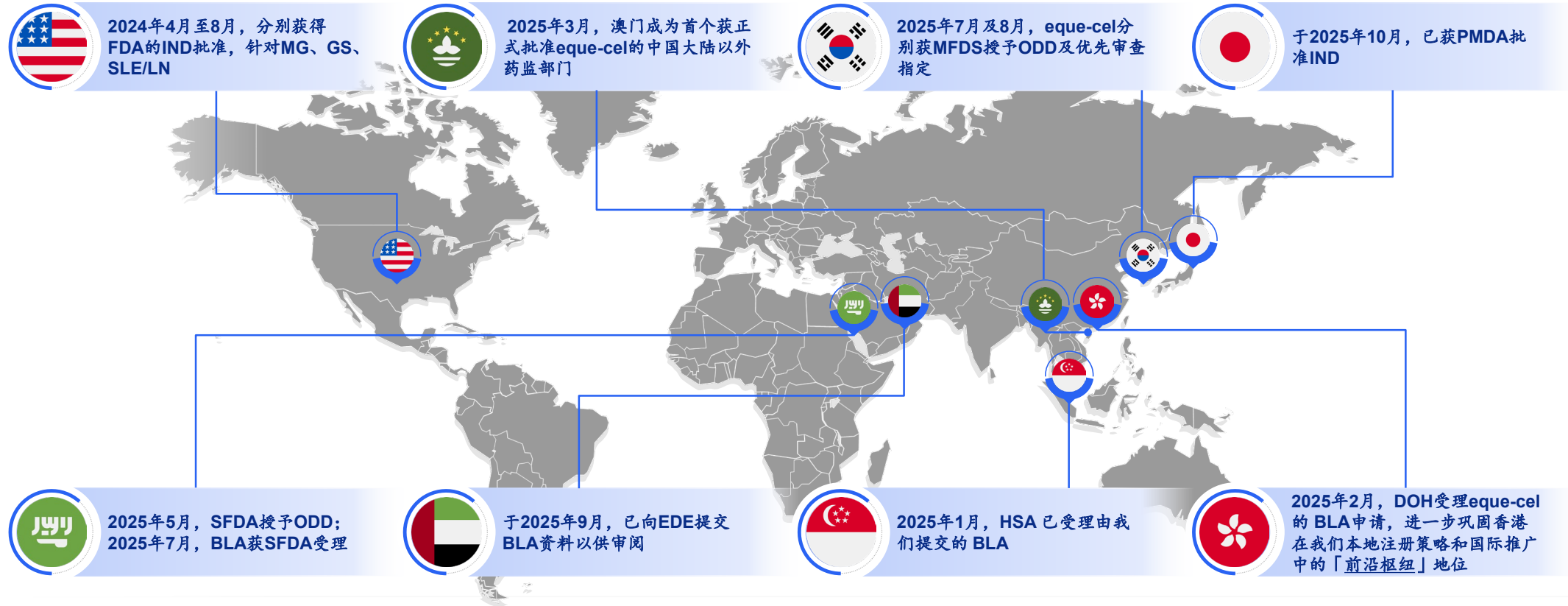
国际化和商业化



高效推进eque-cel全球临床开发及注册

充分释放核心产品的临床及商业价值

我们的国际注册策略结合了直接注册与桥接及多中心研究。在CMC能力基础上，我们正运用迄今为止的临床数据，以支持向澳门、香港、新加坡、沙特阿拉伯、阿联酋、马来西亚及韩国等地监管机构注册，同时通过桥接研究于日本及巴西寻求市场批准，以促进eque-cel于全球商业化



中国市场的一流商业化能力及初见成效的海外商业拓展布局

成熟的商业化平台和不断扩大的全球布局，展现强大的执行能力和国际竞争力

驯鹿已在中国建立最全面的ATMP商业化平台之一



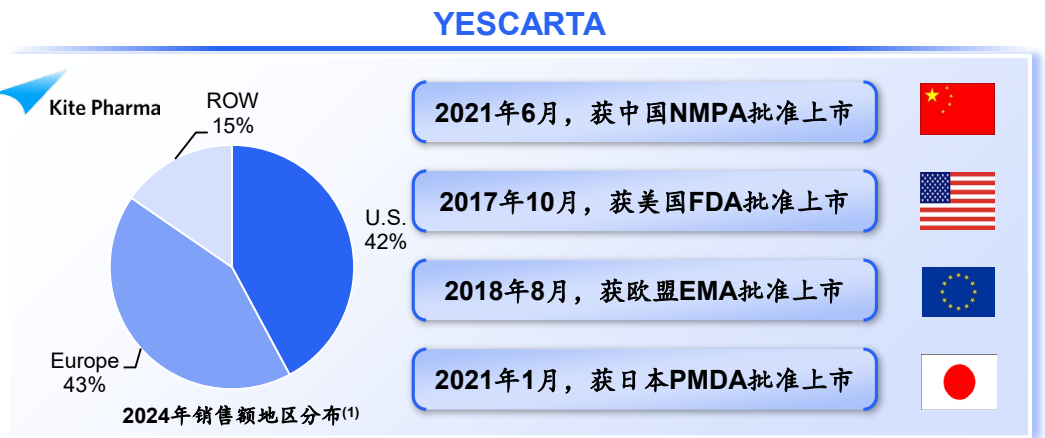
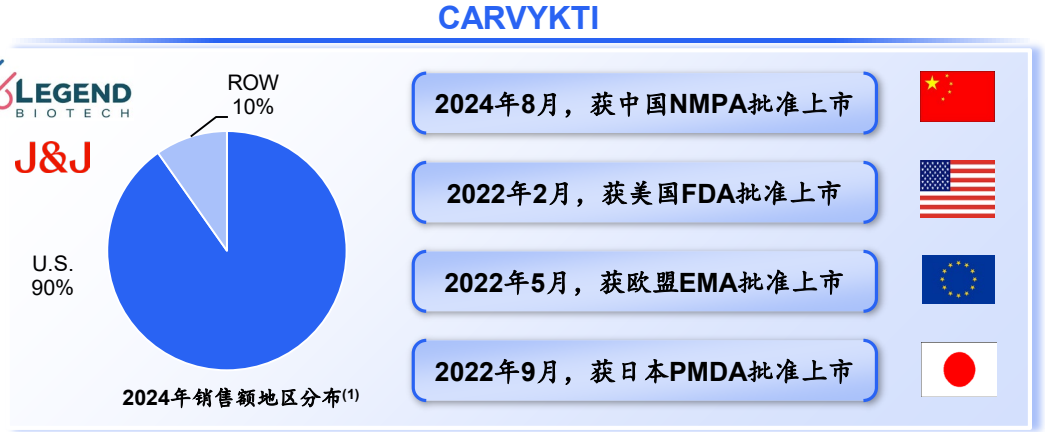
- 福可苏®的快速推广为中国ATMP领域商业化执行树立行业标杆
- 福可苏®推出一年内已在**100多家**TOP医院临床使用
 - 2024年福可苏®收入达到人民币191.8百万元，在中国治疗MM的CAR-T细胞疗法市场中份额接近**70%**
 - 已于中国超过**40个城市**建立超过**95家DTP药房**、**21家院内经销公司**及超过**180家治疗中心**的销售网络

- 在保持保质量治疗和合规的同时提升患者就医可及性和可负担性
- eque-cel已纳入中国**40个**商业保险产品及**142个**地区的惠民保险
 - 2025年12月，eque-cel成功纳入**国家商保创新药目录**

（在中国复杂的医疗保健环境中取得成功） + （全球合作伙伴日益增加的认可）

使我们成为少数能够提供从发现和开发到大规模商业化和国际准入的端到端价值的公司之一

驯鹿采用不同于其他CAR-T公司的差异化海外拓展路径



注：
1. 数据来源：公开信息披露

中国市场的一流商业化能力及初见成效的海外商业拓展布局（续）

已就推动全球商业化模式取得初步成功，扩大全球患者用药机会

- 符合PIC/S标准的GMP生产系统结合全球监管专业知识和成熟的可比性框架，为多区域供应、技术转移和共同商业化提供坚实基础
- 依托我们多层次的全球治疗平台，我们正在透过NPP和患者转诊计划促进早期国际准入，同时推进在特定地区的市场准入和保险纳入

多区域供应

“中国制造，全球供应”模式，旨在高效地将先进的CAR-T细胞疗法推向国际市场

端到端的制造和CMC能力，为全球扩张提供必要的基础设施，从而能够在统一的质量标准下实现区域制造、跨境技术转移和多区域临床试验供应

一体化CAR-T解决方案

透过我们的“中国解决方案”将整合平台变现，其为一个全面、可出口的合作模式，涵盖制程开发、技术转移和GMP生产支援

为海外合作伙伴提供一体化全周期解决方案，包括一体化自动化细胞处理设备、质粒、慢病毒载体、耗材以及技术转移和相关服务

共同商业化

积极与跨国制药公司、区域医疗保健集团和学术中心开展业务拓展(BD)活动，促成在许可、共同开发和区域制造方面的持续合作与伙伴关系讨论，以加速我们自身免疫资产的临床开发和未来的商业化



患者转诊计划

已建立一套全面的患者旅程管理系统，以实现高效的海外患者转诊和治疗服务交付

透过病患转诊/医疗旅游项目，海外患者可在中国获得认证的治疗中心接受eque-cel治疗，已下达40+份订单

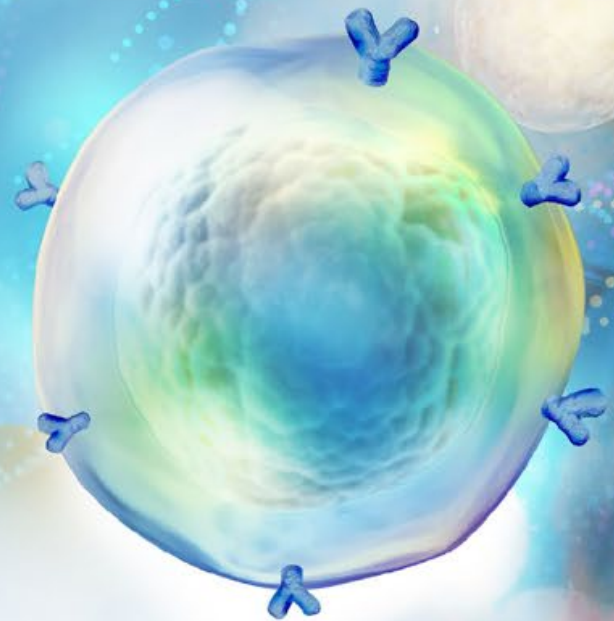
指定患者计划(NPP)

为中国内地首间透过香港NPP实现国产CAR-T细胞疗法跨境供应的公司，至今已完成多个成功案例

全球大部分地区仍未能取得商业化的BCMA CAR-T治疗，在该等市场率先推进NPP为我们国际化布局的重要一环

章节 3

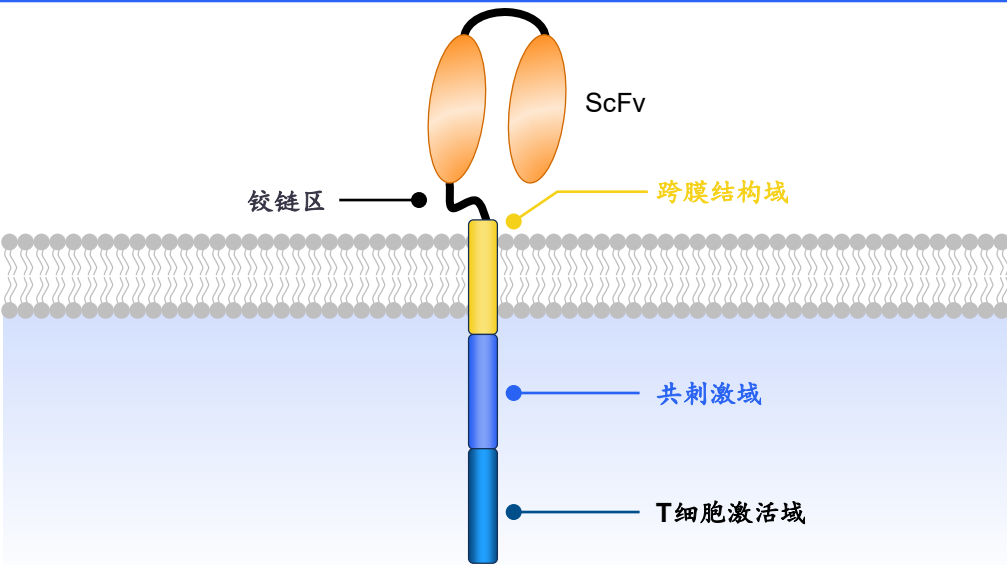
产品管线介绍



Eque-cel – 同类首创与潜在最佳的BCMA CAR-T疗法

概览

作用机制和竞争优势



全球首个全人源CAR-T细胞疗法
 中国首个获批的BCMA靶向CAR-T疗法

利用全人源scFv靶向BCMA以大幅降低免疫原性

- 该CAR由一个靶向BCMA的细胞外结合域scFv与能够激活及维持T细胞的细胞内信号传导域（包含4-1BB共刺激域和CD3-ζ激活域）融合而成
- 注入人体后，经工程化T细胞上CAR与恶性浆细胞上的BCMA结合，引发细胞因子释放细胞毒性作用

竞争优势

- 优化的CAR结构设计，为全人源CAR结构且具有最佳且一致的BCMA结合能力
- 较其他靶向BCMA的CAR-T细胞疗法更卓越的安全性和有效性
- 稳健且自给自足的制造能力，能够独立生产慢病毒载体
- 全面的全球注册与开发策略，充分利用中国的制造优势，推进海外市场本地化监管及市场准入策略
- 全面商业化策略，已在中国建立全面的ATMP商业化平台，并推动全球商业化
- 全面的适应症扩展计划，对自身免疫病等其他适应症显示出良好疗效

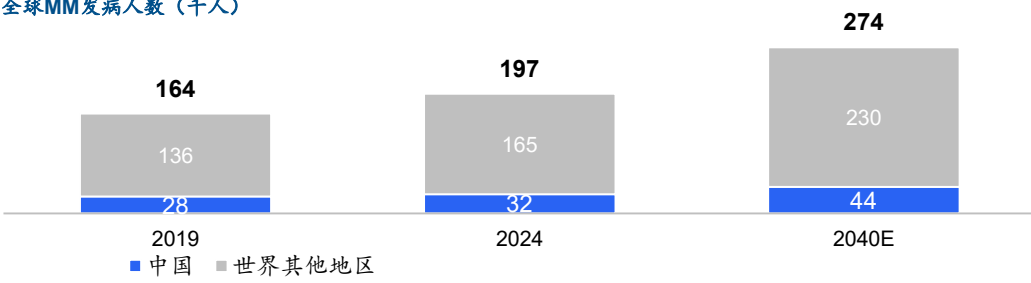
Eque-cel – 同类首创与潜在最佳的BCMA CAR-T疗法（续）

市场机遇和竞争

MM

- MM是骨髓中浆细胞的一种癌症，发生于健康的浆细胞变成恶性并不受控制地增殖。常导致患者的骨骼损害，包括溶骨性病灶、骨质疏松症和病理性骨折
- 靶向B细胞相关抗原（包括BCMA）的CAR-T细胞疗法，已成为治疗MM的关键策略。靶在经过大量预防治疗的复发或难治患者中显示了持久的反应，并获得美国、欧盟和中国的监管批准

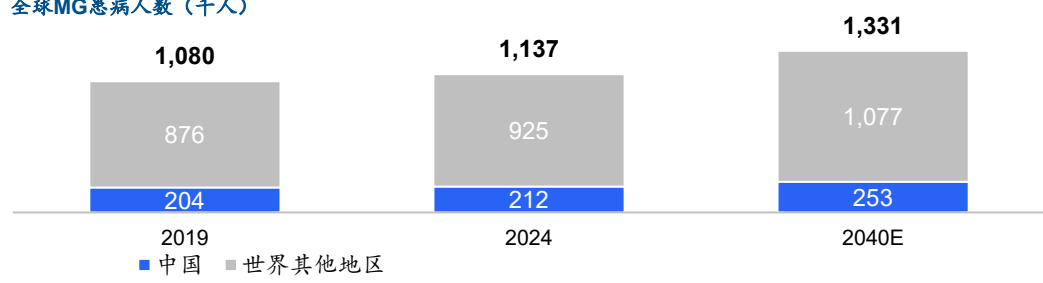
全球MM发病人数（千人）



MG

- MG是一种自体免疫性神经系统疾病，特征是神经肌肉接合处的传导缺陷，被认为是抗体介导的自身免疫疾病的典型例子
- 全球MG治疗选择仍然有限，特别是对于全身性或难治性疾病患者。靶向BCMA的CAR-T细胞疗法为MG提供一种潜在治疗方案，其消除产生致病性AChR或MuSK自身抗体的B细胞或浆细胞

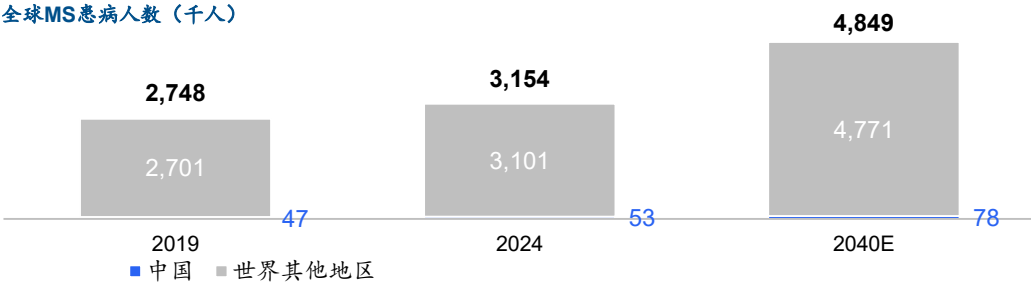
全球MG患病人数（千人）



MS

- MS是一种免疫介导的CNS炎症性疾病，会导致时间及空间上分散的脱髓鞘病灶
- 尽管DMT治疗已改善许多患者的治疗结果，但持久的神经保护和可逆的疾病进展仍然难以实现，全球MS的治疗仍存在庞大未被满足的需求

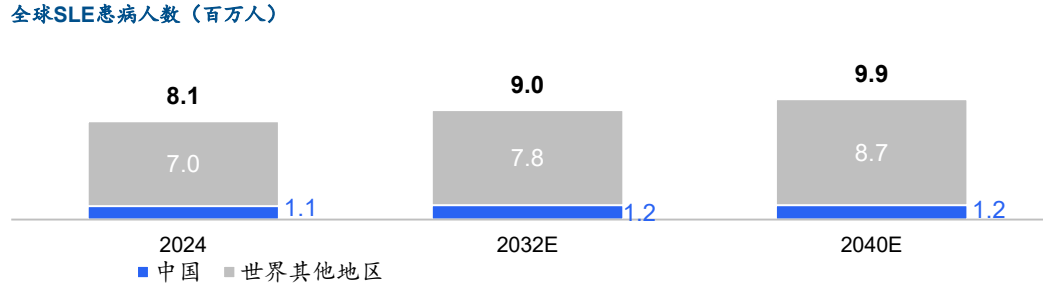
全球MS患病人数（千人）



SLE

- SLE为一种多系统自身免疫疾病，免疫系统会攻击身体，导致皮疹、关节疼痛和肿胀、发烧、胸痛、脱发、口腔溃疡、淋巴结肿大以及全身乏力等症状
- BCMA在浆细胞中高度表现，尤其是在SLE中产生致病性自身抗体的CD19+CD138+亚群中，从而为SLE治疗提供新方法

全球SLE患病人数（百万人）



数据来源：弗若斯特沙利文

Eque-cel – 同类首创与潜在最佳的BCMA CAR-T疗法（续）

临床数据对比

在多项关键指标上较其他CAR-T细胞疗法表现出明显优势

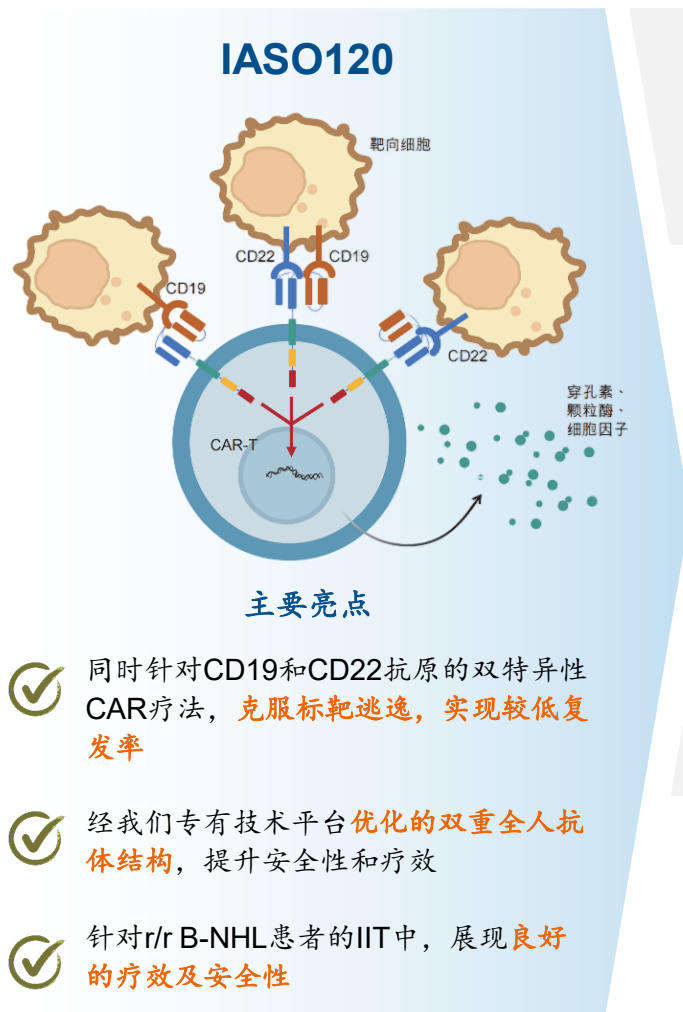
	福可苏®		Abecma®	Carvykti®	赛恺泽®
	未曾接受过CAR-T 细胞疗法的患者 N=97	所有患者 N=109	N=128	N=97	N=102
批准	中国2023年6月		美国2021年3月	美国2022年2月	中国2024年2月
总缓解率	98.9%	96.3%	73%	97.9%	92.2%
≥CR	88.4%	83.2%	33%	82.5%	71.6%
mPFS（月）	35.9	30.5	8.8	34.9	/
12个月 PFS	85.5%	80.0%	/	/	76.3%
≥3级 CRS	1.0%	0.9%	5.5%	5.1%	6.9%
≥3级 CAR-T 相关神经 毒性（包括 ICANS）	0%		4%	11%	0%
帕金森综合征	0%		/	5%	0%
MDS 发生率	0%		2/137	7/97	0%
AML 发生率	0%		0%	3/97	0%

Eque-cel – 同类首创与潜在最佳的BCMA CAR-T疗法（续）

广泛适应症潜力与临床开发计划

≥4L r/r MM	- 于2023年6月获得NMPA的附条件BLA批准，并于2025年10月提交完全销售批准申请 - 已于2025年9月向PMDA提交进行关键临床试验的IND申请，并于2025年10月获得批准；预计将于2027年上半年完成试验，并于2028年根据收集的数据提交BLA
2L/3L r/r MM	- 预计将于2026年下半年完成于中国正在进行的III期临床试验的患者招募。根据在中国进行的III期临床试验收集的数据，计划于2028年提交BLA，预计2029年获得批准 - 此外，计划于2026年上半年向PMDA提交IND申请，于2026年下半年启动试验，并于2027年下半年完成患者招募
高危NDMM	- 正在进行IIT研究，已经显示其可安全有效地用于一线治疗：所有NDMM患者均对治疗有反应，ORR达到100%，其中93.8%的患者达到sCR或CR - IIT研究预计将于2025年第四季度完成
MG	- 根据IIT研究，在两名具有不同自身抗体谱的难治性MG患者的IIT试验中显示出令人信服的疗效：一名33岁患有AChR-和Titin-IgG阳性疾病的女性，实现了功能性和血清学缓解，肌力恢复，停用对症治疗，并在21个月内维持缓解，包括一次成功的怀孕和分娩；一名60岁患有MuSK-IgG4阳性MG的女性，显示出快速的功能恢复 - 计划于2026年上半年在中国开始I期临床试验患者招募，并同时在美国进行
其他自身免疫疾病 (MS • SLE/LN • IIM)	- 正在中国进行的一篮子IIT的患者招募预计将于2025年第四季度完成 - 在美国，计划于2026年下半年开始eque-cel治疗MS的I期临床试验，并于2027年开始其治疗SLE/LN的I期临床试验

IASO120 – 潜在同类首创、全人源CD19/CD22双靶点在研CAR-T细胞疗法



设计及机理

- **潜在最佳、自研全人源、双靶点CAR-T疗法**，旨在通过靶向CD19和CD22治疗B细胞恶性肿瘤，如B-NHL及B-ALL，克服现仅有靶向单一抗原CAR-T细胞疗法的局限
- **新颖的双特异性CAR构建**，采用串联或二价设计，以解决与单靶点CAR-T疗法相关的复发问题，从而增强长期疗效

市场潜力 (1)

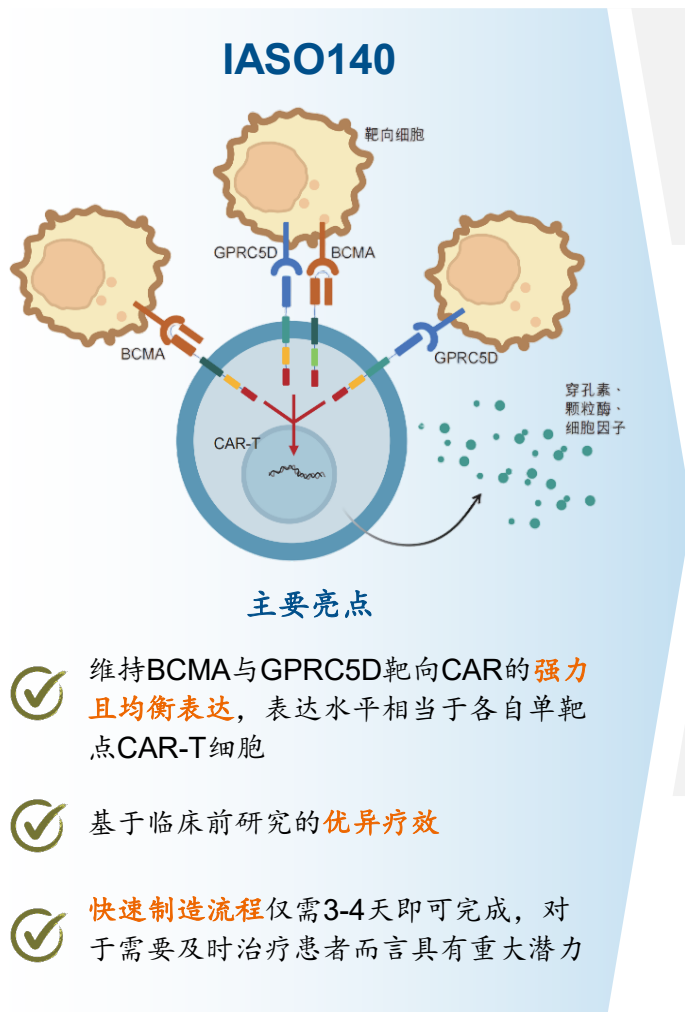
- 淋巴瘤起源于淋巴系统的血液恶性肿瘤，主要分为霍奇金淋巴瘤及非霍奇金淋巴瘤，弥漫大B细胞淋巴瘤（DLBCL）为其中最常见子集
- **DLBCL的治疗仍有庞大的未满足医疗需求**，且复发性或难治性DLBCL的治疗选择有限，患者对更安全、更耐受的治疗方法需求迫切
- IASO120是**中国临床进度最快的**针对DLBCL的双特异性CAR-T细胞疗法

临床数据概要

- **针对r/r B-NHL患者的IIT中**，展现出良好的安全性及令人鼓舞的疗效
- **最佳ORR为65.2%**，长期随访显示缓解持久，13名CR患者中仅有2名在11.3个月和23.95个月时复发，且达到最佳缓解的中位时间为2.83个月
- **未报告5级AE。大多数CRS病例为1-2级（82.6%）**，只有一名患者出现3级CRS；所有事件均可逆，且未观察到免疫效应细胞相关神经毒性综合征（ICANS）病例

临床开发计划

- 正在进行一项针对r/r B-NHL患者的开放标签、多中心**III期临床试验**
- 预期完成商业规模制造流程验证后，**2026年下半年**开始II期临床试验患者招募，作为B-NHL的三线或后线治疗



设计及机理

- 同时识别**BCMA和GPRC5D的双靶点CAR-T细胞疗法**，以解决BCMA靶向治疗r/r MM中存在的抗原逃逸问题，特别适用于接受BCMA或GPRC5D靶向治疗后复发的患者
- 采用**双顺反子构建体**，在存在抗原异质性的情况下仍可提高完全根除肿瘤的可能性
- 利用专有的**FAST CAR-T平台开发**，具有快速、高效的生产优势，在可扩展性、速度及成本效益方面均具有优势

市场潜力 (1)

- BCMA与GPRC5D的双靶点策略为双特异性T细胞疗法提供了互补优势，亦能减轻抗原逃逸风险，从而维持细胞毒性压力并克服肿瘤异质性问题
- 全球已有**两项**同时针对BCMA及GPRC5D的CAR-T细胞疗法在研药物进入临床开发阶段，其中一项为我们的IASO140

临床前研究

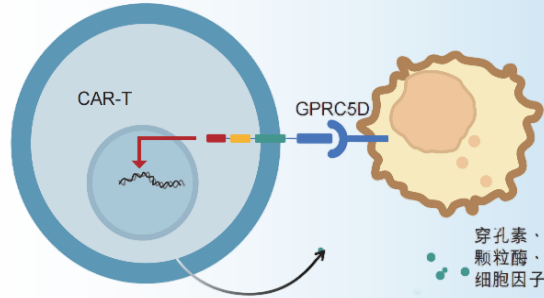
- IASO140功能表现在体外与体内模型中均与单靶点CAR-T细胞相当**
 - **细胞毒性实验**中，IASO140对表达BCMA或GPRC5D的肿瘤细胞展现强大活性，同时具有强健的细胞因子分泌及增殖能力
 - **动物研究**中得到一致的结果，IASO140亦显示出与单靶点CAR-T相当的有效肿瘤控制。

临床开发计划

- 正在进行于r/r MM或PCL患者的**IIT实验**，预计2025年Q4完成患者招募
- 2027年下半年**向NMPA提交IND申请，用于治疗既往至少接受过三线治疗后病情进展的r/r MM

IASO118 – 针对GPCR5D的全人源在研CAR-T细胞疗法

IASO118



主要亮点

- ✓ 抗原识别域源自我们专有全人源单域抗体库，具有**高亲和力、高特异性和低免疫原性的优势**
- ✓ 专有技术平台筛选获得，对GPCR5D显示出**最佳结合亲和力**
- ✓ 临床前研究证实IASO118优于基准CAR-T产品，具有**增强的抗肿瘤活性**

设计及机理

- **针对GPCR5D的全人源CAR-T细胞疗法**，为对BCMA靶点治疗抗原逃逸的MM患者而设计，可作为后续或联合策略
- GPCR5D在**MM细胞中高度表达**，这种选择性表达谱提供有利的治疗窗口，成为免疫效应细胞疗法理想的靶点
- **利用经基因修饰的T细胞表达特异性识别GPCR5D的CAR**，具有克服抗原缺失等耐药机制，并与BCMA靶向剂联用以应对疾病异质性的潜力

市场潜力 (1)

- **GPCR5D是最近崛起具有前景的替代靶点**，独立于BCMA表达，在MM患者中广泛表现，新诊断MM患者中GPCR5D中位数阳性率为**32.68%**
- 全球有六种靶向GPCR5D的在研药品处于临床开发阶段，其中美国最快产品已进入III期，中国有三种在研药品处于开发阶段

临床研究

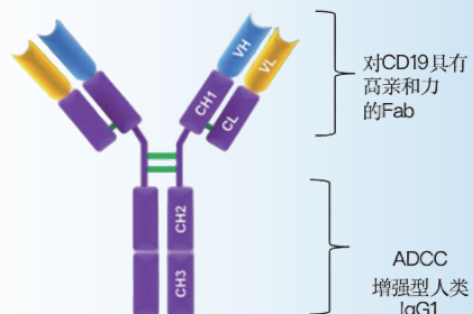
- **IIT研究**显示在MM患者中显示出令人鼓舞的结果，包括之前接受过BCMA CAR-T细胞疗法的患者
 - 高达**94.4%(17/18)的ORR**，**72.2%(13/18)的患者达到CR/sCR**，并实现**MRD阴性(88.2%)**，表明其疗效良好
 - 安全性方面，**CRS多数病例属轻度(1级)**，并在治疗后全部消退，仅观察到**1例ICANS**，亦已消退
 - 相关研究结果已发表在国际顶级期刊《Blood》

临床开发计划

- 已获**IND批准I期**临床试验，预计**2026年下半年**开始招募既往至少接受过三线治疗后病情进展的r/r MM患者

IASO782 – 抗CD19单克隆抗体，潜在首创疗法

IASO782



主要亮点

- ✓ 全人源抗CD19单克隆抗体，具有**低免疫原性**
- ✓ 工程改造增强ADCC，显著**改善靶细胞杀伤活性**
- ✓ IASO782 CD19序列有长期专利保护
- ✓ **优异的临床前疗效**，体外及体内研究中表明显著B细胞清除能力

设计及机理

- 全人源抗CD19单克隆抗体，**广泛适用于治疗自身免疫疾病**，例如原发免疫性血小板减少症（ITP）、温抗体型自身免疫性溶血性贫血（wAIHA）、SLE等
- **在Fc区域进行工程改造**，以增强ADCC，透过ADCC及ADCP两种免疫介导机制⁽²⁾，可以清除CD19+ B细胞及浆细胞，从而减少自身抗体产生，治疗抗体或B细胞介导的自身免疫疾病

市场潜力 (1)

- ITP是一种后天性自身免疫性出血性疾病，全球患病率持续上升，现有治疗通常无法长期缓解，患者**持续反应率低于60%**，且**无任何真正根治疗法**
- wAIHA为最常见的自身免疫性溶血性贫血，面临显著的未满足医疗需求，**全球无任何药物获准用于wAIHA治疗**
- IASO782为中国**唯一针对ITP和wAIHA**正在临床开发的靶向CD19抗体疗法

临床前研究

- **体外临床前研究**，IASO782相较于基准CD19靶向疗法展现出优异疗效。
 - 对细胞表面的CD19具有高亲和力结合，可实现更高效且选择性的B细胞靶向
 - 增强结合提升体外B细胞清除效率，在消除致病或恶性B细胞方面具有更大潜力
- **hCD19人源化HE小鼠的体内临床前研究**，单次给药显示快速持续的B细胞耗竭
 - 给药后B细胞计数急剧下降，表明强劲的体内活性
 - 下降持续时间达14天，反映持久PD效应及其在更长期间有效靶向B细胞的潜力

临床开发计划

- **已获NMPA及美国FDA的IND批准**，以启动IASO782用于ITP及wAIHA患者的临床试验，正在中国进行I期临床试验
- 预计**2026年下半年**完成中国ITP和wAIHA的I期临床试验Ia期阶段患者招募
- 预计**2027年上半年**开始在中国进行SLE患者的Ib期临床试验的患者招募

注：
1. 根据弗若斯特沙利文
2. 抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用（ADCC）通过集合免疫效应细胞（如自然杀伤细胞（「NK细胞」））消除CD19+细胞；抗体依赖性细胞吞噬作用（ADCP）促进巨噬细胞吞噬并清除靶向细胞

In vivo CAR-T技术平台

平台技术

- 我们正在全球推进*in vivo* CAR-T技术,该技术能够直接在患者体内生成CAR-T细胞,为细胞疗法的发现、制造和输送方式的范式革新
- 我们专有的慢病毒载体工程系统包括一种经修改的包膜糖蛋白和一种T细胞靶向的配体,以实现体内循环T细胞的高度选择性转导

1

载体设计

- 使用复制缺陷型慢病毒携带CAR RNA
- 采用突变的Coc1包膜以破坏与天然受体 (LDL-R) 的结合、保留融合活性、对补体介导的灭活 (人血清) 具有耐受性

2

免疫逃逸

- 免疫屏障修饰: MHC I基因敲除、CD47过表达
- 防止巨噬细胞和T细胞清除病毒载体

3

T细胞特异性与激活

- 表达 T 细胞特异性结合分子 (靶向T细胞)、T 细胞特异性激动剂结合分子 (激活T细胞)
- 通过T 细胞特异性启动子/增强子防止非 T 细胞表达

4

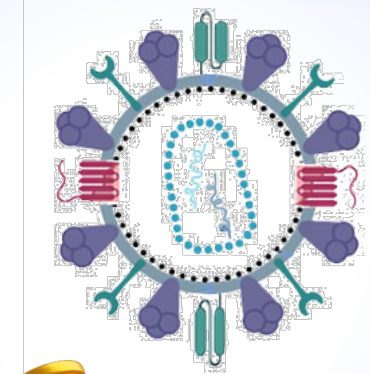
生产制造

- 具备端到端、大规模 GMP 生产能力
- 从研发到商业化的自有端到端产能

战略意义

巩固在细胞疗法创新领域的领先地位

强化作为少数拥有开发、生产和商业化*ex vivo*和*in vivo* CAR-T产品的综合专业知识的公司的长期竞争优势



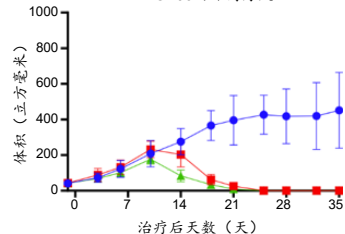
核心亮点

In vivo CAR-T技术平台 (续)

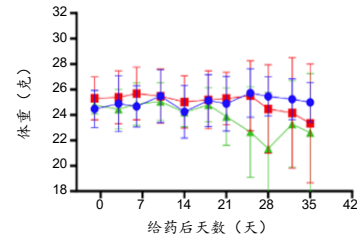
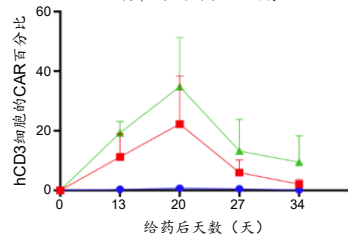
临床前数据

利用人源化VHH的 BCMA靶向in vivo CAR-T (IASO206)

IASO206的体内疗效

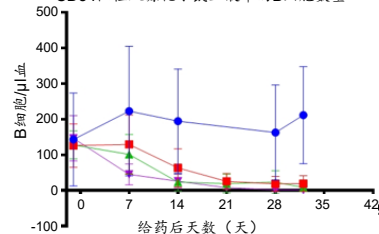


血液中hCD3的CAR+百分比

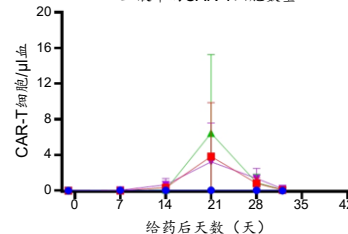


利用人源化scFv的 CD19靶向in vivo CAR-T (IASO207)

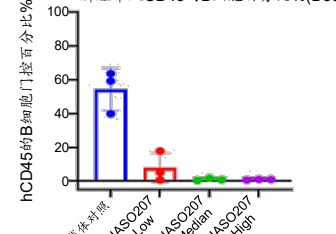
CD34阳性人源化小鼠血液中的B细胞数量



血液中的CAR-T细胞数量

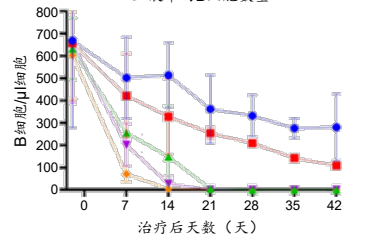


脾脏中人CD45的B细胞百分比(D35)

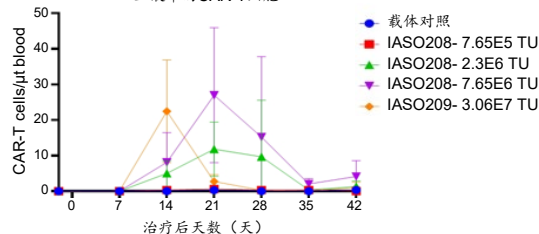


利用人源化VHH的 CD20靶向in vivo CAR-T (IASO208)

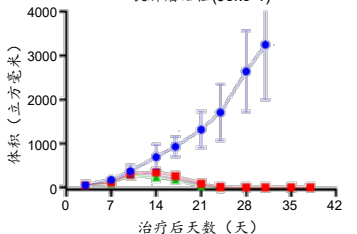
血液中的B细胞数量



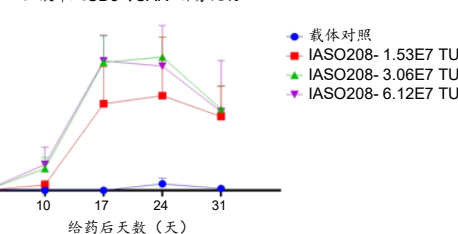
血液中的CAR-T细胞



抗肿瘤活性(Jeko-1)



血液中人CD3的CAR+百分比



In vivo CAR-T技术平台（续）

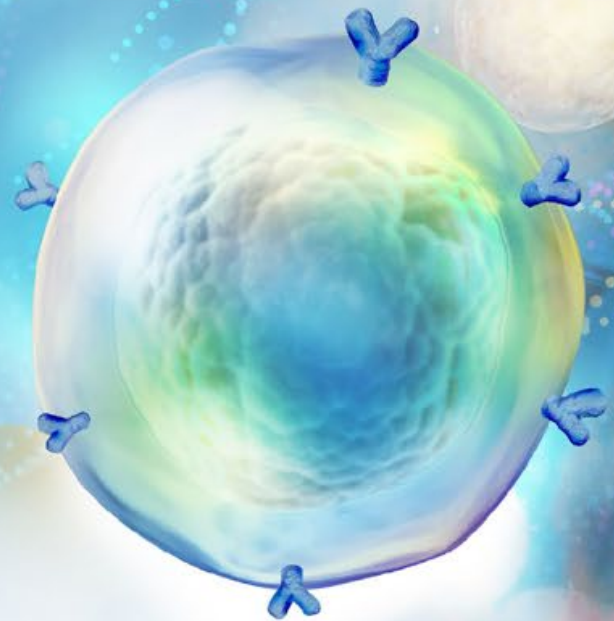
产品管线

- 我们正在开发一系列*in vivo* CAR-T在研产品，用于治疗血液恶性肿瘤和自身免疫疾病
- 凭借我们专有的载体设计，实现**精确的免疫细胞靶向和可控的CAR表达**，旨在提高安全性和治疗效果；该平台具有**模块化灵活性**，能够按顺序或组合递送不同的CAR构建体，以实现多特异性或可调的免疫缓解

项目	靶点	适应症 ⁽³⁾ (治疗方案) ⁽⁴⁾	临床前	I期	目前状态 / 预期下一个里程碑
IASO206	BCMA	n/r MM (≥4L)	IIT		预期2026年上半年开始IIT患者招募 预期2027年上半年向美国FDA及NMPA提交IND申请
IASO207	CD19	B-NHL (≥3L) 及 SLE	IIT		预期2025年第四季开始IIT患者招募 预期2026年下半年向美国FDA及NMPA提交IND申请
IASO208	CD20	B-NHL (≥3L)	IIT		预期2025年第四季开始IIT患者招募 预期2026年下半年向美国FDA及NMPA提交IND申请
IASO209	未披露	未披露	临床前		处于临床前开发阶段
IASO210	未披露	未披露	临床前		处于临床前开发阶段

章节 4

生产能力



稳健且自给自足的制造能力

独立生产eque-cel所使用的慢病毒载体的能力，是我们实现快速制造周转、持续制程创新、产量提高及全球供应的核心战略能力

生产设施



位于南京的商业生产基地是中国获得**PIC/S认证的ATMP生产设施**，其设计与运营符合**美国FDA、欧洲EMA及日本PMDA**等全球主要监管机构的严格标准



ex vivo 慢病毒载体

专有的慢病毒载体平台专门为eque-cel设计，可实现**一致的转导效率和稳定的CAR表达**。为eque-cel开发的整合LVV-CAR-T制造流程可**减轻供应风险、降低成本并实现快速制造周转**



In vivo CAR-T产品

在现有药物研发平台的基础上，我们计划持续升级**in vivo**平台及**FAST CAR-T**平台，以支持**下一代in vivo CAR-T药物**的开发



产能扩增

我们具备涵盖质粒、病毒载体和CAR-T细胞的全周期生产能力，以及内部分析和质量控制能力。目前批准的年产能可为**500**名患者，我们计划在一年内将产能扩大到**1,000**名患者

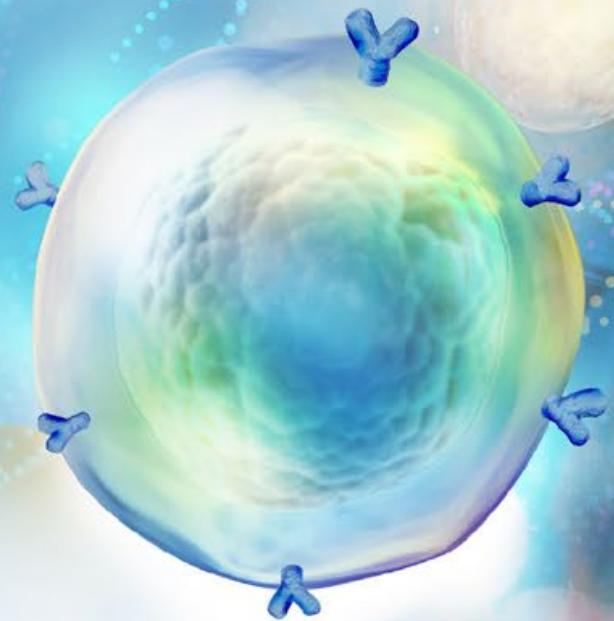


跨境供药

拥有获得PIC/S认证的ATMP生产基地，确保**全球供应准备**，进一步巩固作为具有**全球竞争力**的细胞疗法制造商的地位

章节 5

财务概览

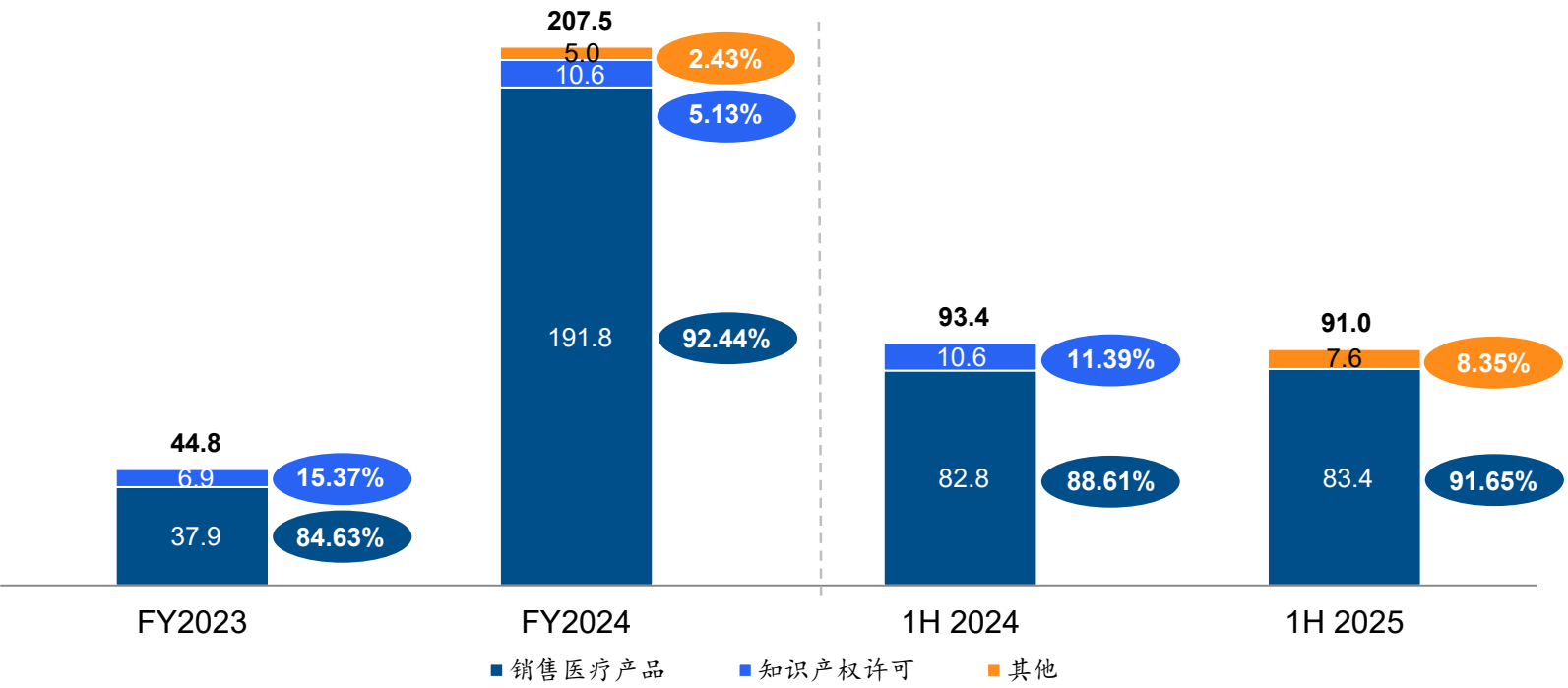


收入及毛利率

2023–2025上半年收入构成及毛利率情况

收入分析

(人民币百万元)



- 公司收入主要来源于2023年6月在中国获得附条件批准Equecel的医疗产品销售、知识产权许可及其他服务
- 按地域市场划分，公司大部分收入来自中国内地的销售，截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年6月30日止六个月，分别占比84.6%、91.6%、88.6%及88.5%

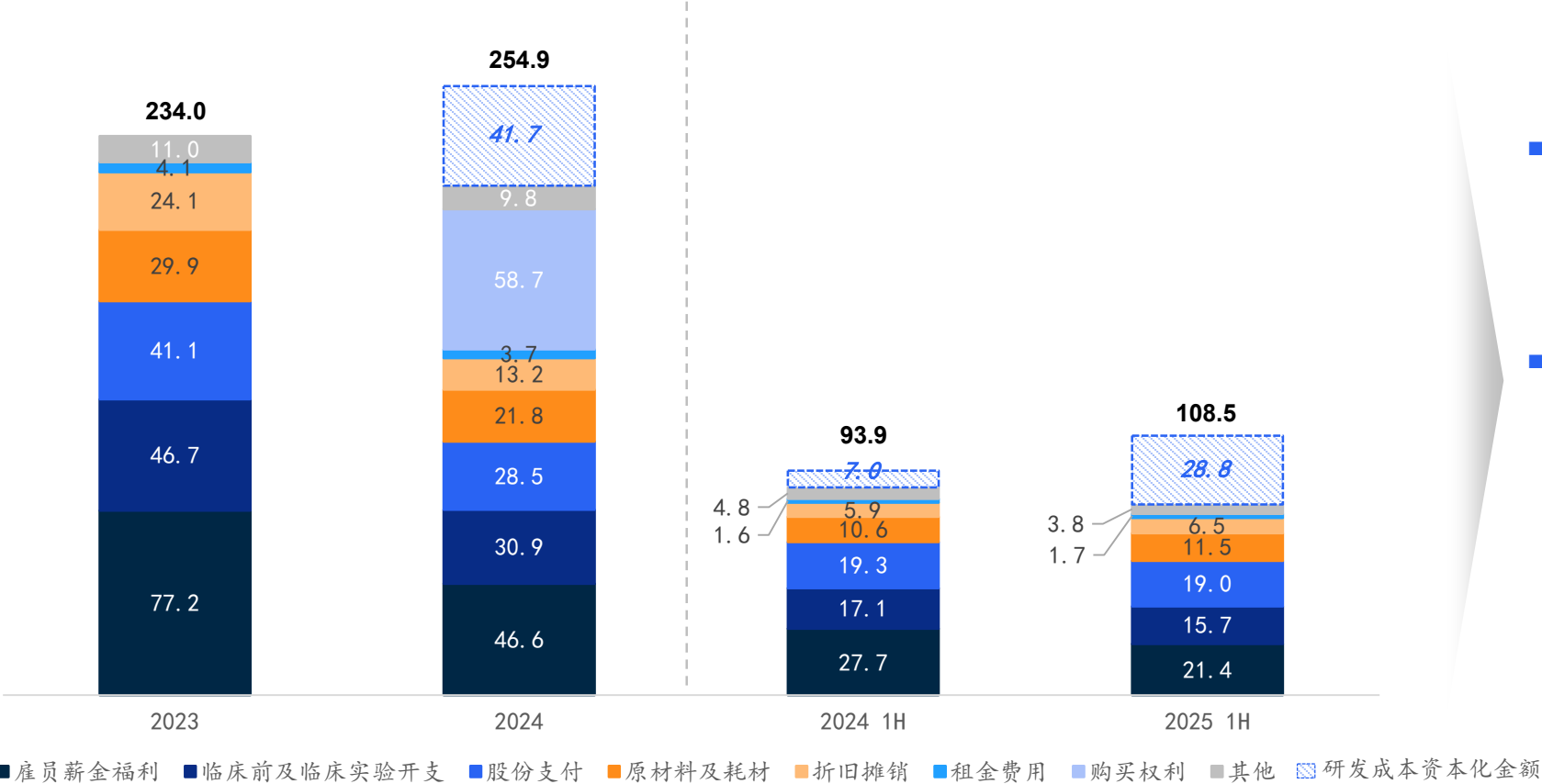
整体毛利率	55.5%	68.0%	71.1%	67.9%
药品销售毛利率	47.4%	66.7%	67.4%	68.6%

资料来源：公司招股书

2023–2025上半年研发投入构成

研发投入分析

(人民币百万元)



- 2023年、2024年全年，及2024年及2025年上半年，核心产品研发投入分别占总研发投入47.1%、67.8%、48.2%及61.7%
- 此外，自2024年起公司开始按开发阶段将核心产品若干产品线的研发投入资本化。于2024年及截至2024年及2025年6月30日止六个月的资本化金额分别为人民币41.7百万元、人民币7.0百万元及人民币28.8百万元

现金流和现金余额

现金情况

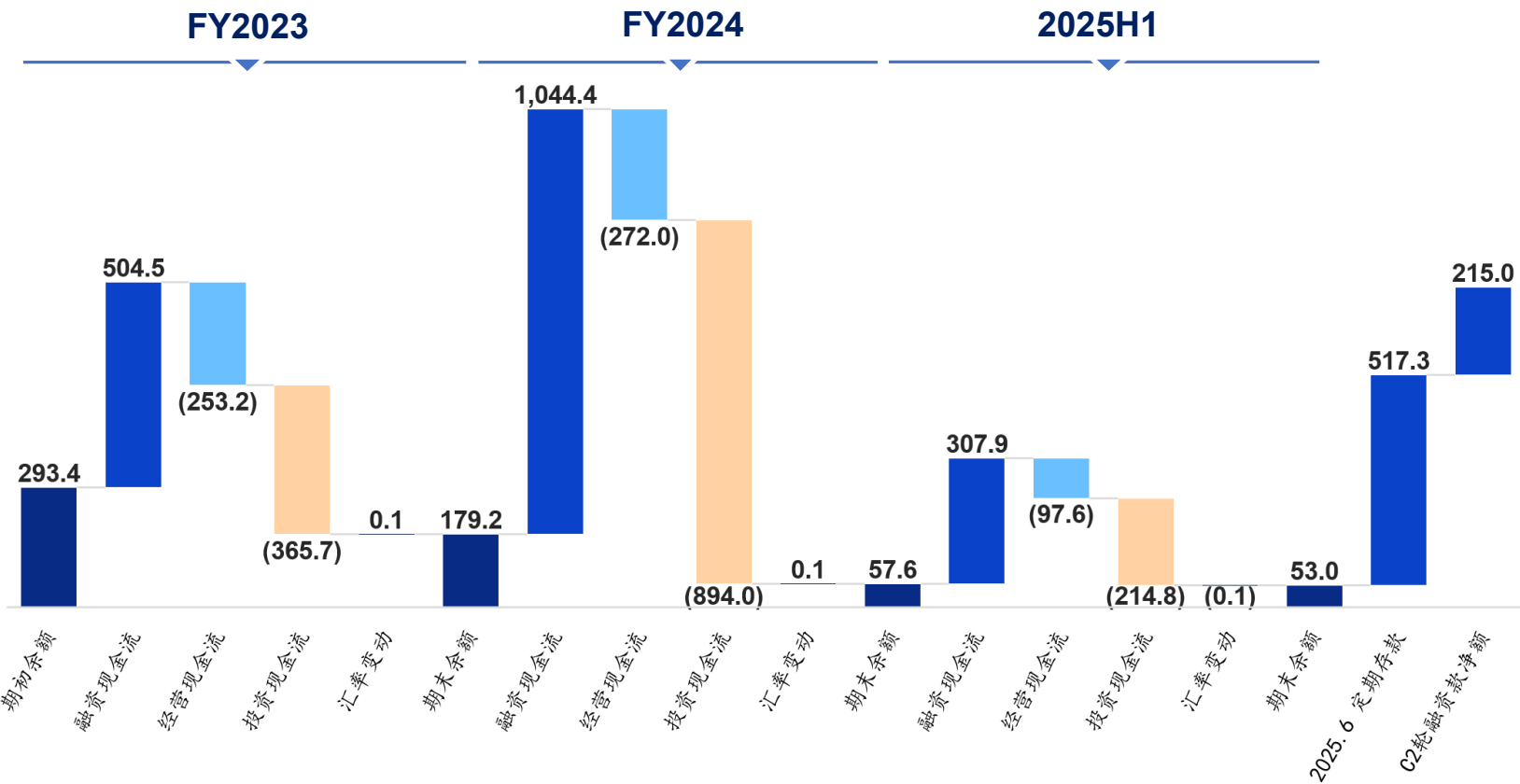
- **现金情况：**截至2025年6月30日，公司的现金及现金等价物为人民币53.0百万元，定期存款为人民币**5.2亿元**，及于2025年下半年的C2轮融资所得款项人民币**2.2亿元**
- **现金消耗分析：**假设未来现金消耗率为截至2025年6月30日止六个月水平的1.1倍，截至2025年6月30日的现金及现金等价物及定期存款，连同C2轮融资所得款项净额，预计可以维持两年以上的运营消耗

> 2年

无IPO融资情况

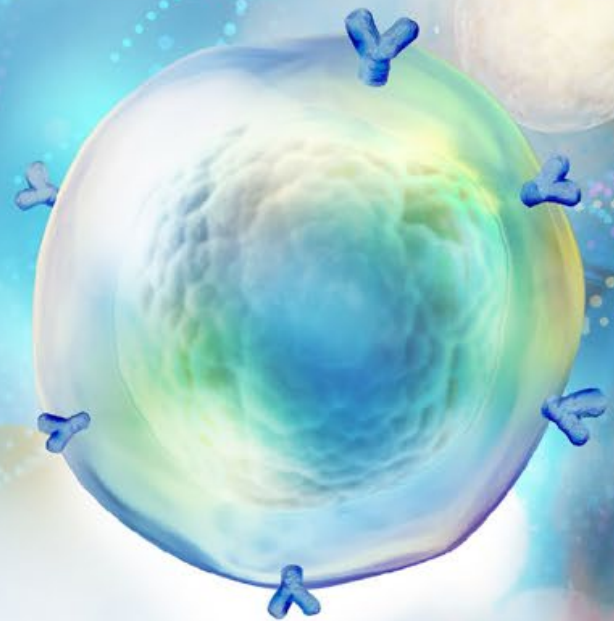
现金余额和净现金流

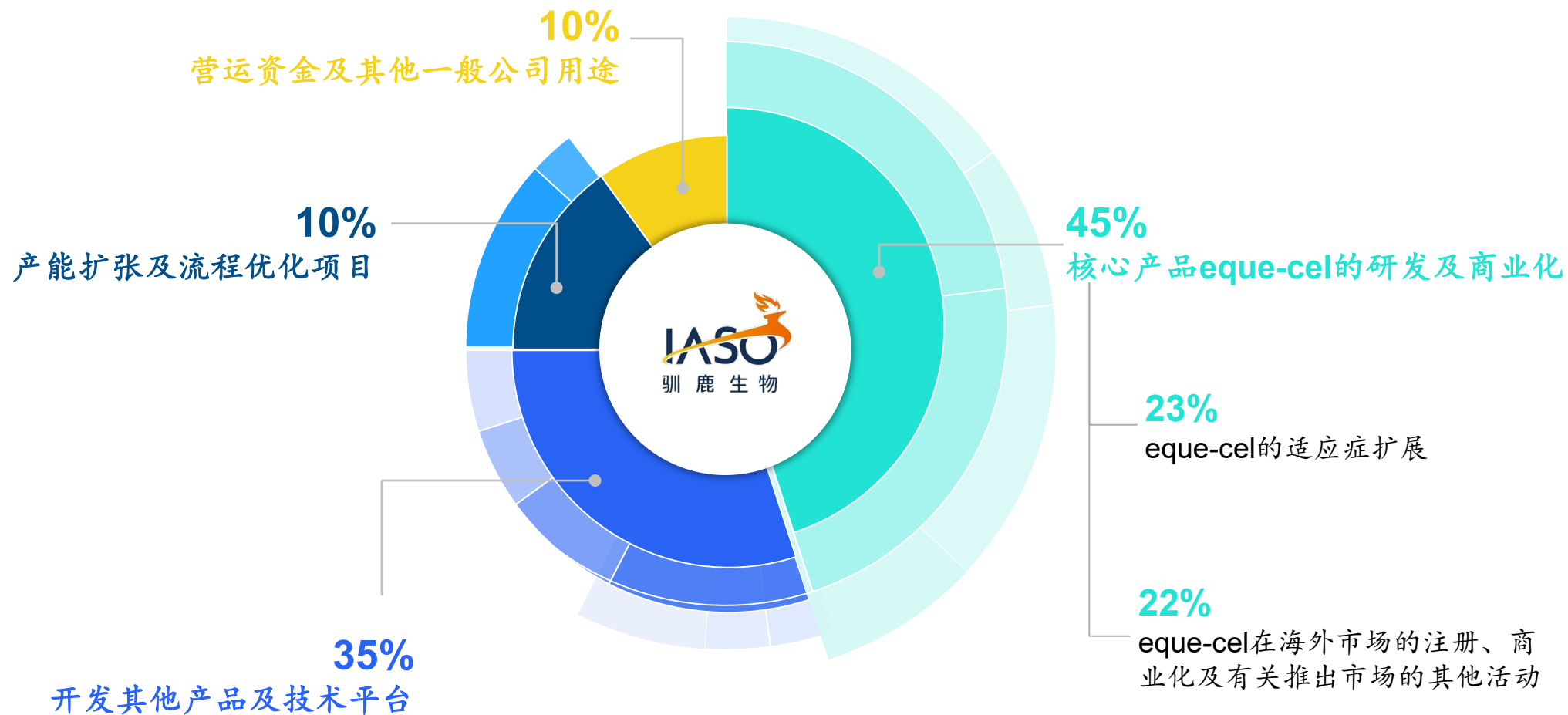
(人民币百万元)



章节 6

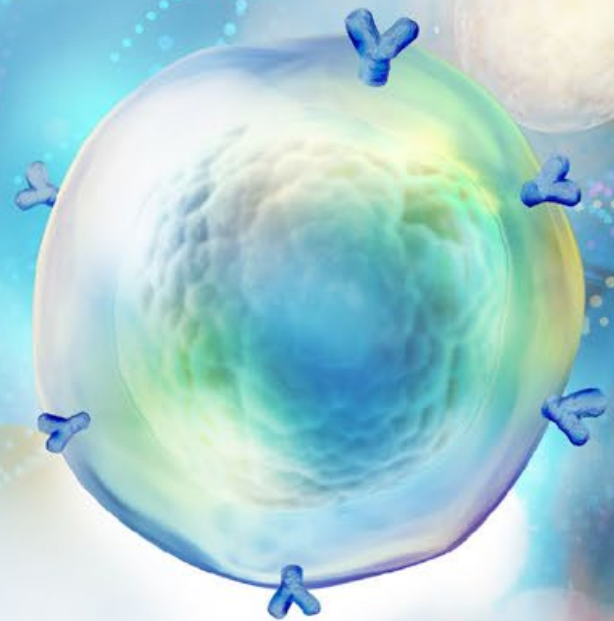
募集资金用途





章节 7

总结



潜在里程碑

可持续动能驱动管线组合高质量发展

未来催化剂

- **CT103A**: 收到NMPA完全销售批准用于r/r MM (≥4L); 在中国和美国启动eque-cel治疗自身免疫疾病的I期临床试验, 包括MG、MS、SLE/LN
- **IASO120**: 针对适应症r/r B-NHL (≥3L), 在中国开始II期患者招募
- **IASO118**: 针对适应症r/r MM (≥4L), 在中国开始I期患者招募
- **IASO207**和**IASO208**: 针对适应症r/r MM (≥4L), 向美国FDA及NMPA提交IND申请
- **IASO782**: 针对适应症ITP及wAIHA, 完成Ia临床试验的患者招募

2025

2026

2027

- **CT103A**: 针对适应症r/r MM (≥4L), 向NMPA提交常规上市许可申请, 于澳门获批BLA, 获新加坡HSA受理BLA, 获香港DOH受理BLA, 获沙特阿拉伯SFDA受理BLA, 向阿联酋EDE提交BLA档案, 于日本获批IND
- **IASO140**: 针对适应症r/r MM (≥4L), 预计Q4完成中国IIT患者招募

- **CT103A**: 针对适应症r/r MM (≥4L), 完成关键临床试验, 并于2028年根据收集的數據提交BLA; 针对适应症SLE/LN, 于美国开始I期患者招募
- **IASO206**: 针对适应症r/r MM (≥4L), 向美国FDA及NMPA提交IND申请
- **IASO782**: 针对适应症SLE, 于中国开始Ib期患者招募

驯鹿于2026年



1个商业化管线

CT103A, r/r MM (≥4L)



1个管线处于III期临床试验

CT103A, r/r MM (2L/3L), 中国



1个管线处于II期临床试验

IASO120, r/r B-NHL (≥3L), 中国



4个管线处于I期临床试验

CT103A, MG, 中国与美国
CT103A, MS, 美国

IASO118, r/r MM (≥4L), 中国
IASO782, ITP及wAIHA, 中国



6个管线处于I/II期临床试验

CT103A, NDMM (高危1L), 中国
CT103A, MS/SLE/IIM等, 中国
IASO140, r/r MM (≥4L), 中国

IASO206, r/r MM (≥4L), 中国
IASO207, r/r MM (≥4L), 中国
IASO208, r/r MM (≥4L), 中国



4个管线处于其他临床阶段

CT103A, SLE/LN, 中国
IASO209, 未披露

IASO210, 未披露
IASO782, SLE, 中国



1

依托中国在细胞治疗领域的全球领先优势，成为先进**ATMP**领域的创新先锋

2

Eque-cel: 同类首创与潜在同类最佳的**BCMA CAR-T**疗法，就治疗**r/r MM**有良好数据，获**NMPA**批准认证，并具前线**MM**及自身免疫疾病中的显著适应症拓展潜力

3

以前瞻性、去风险化的开发方式开发多元化、全面及均衡的产品线

4

整合端到端开发能力，覆盖创新药物研发全周期及**CMC**及临床开发

5

成熟的商业化平台和不断扩大的全球布局，展现强大的执行能力和国际竞争力

6

由世界级专家、行业资深人士及资深创业者组成的远见卓识管理团队，并获得知名投资者支持



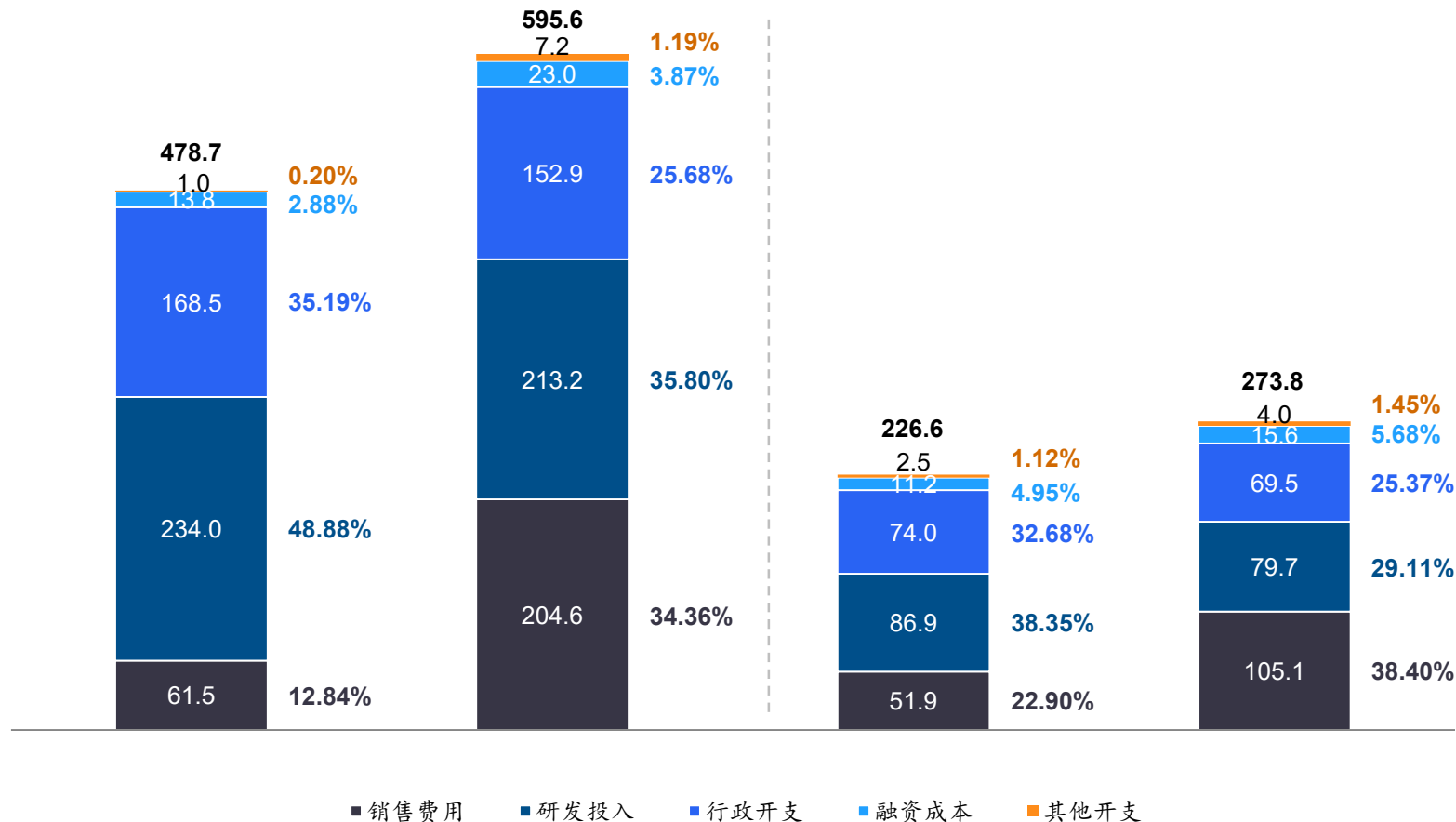
附录 A

财务报表

2023-2025上半年费用构成

费用分析

(人民币百万元)



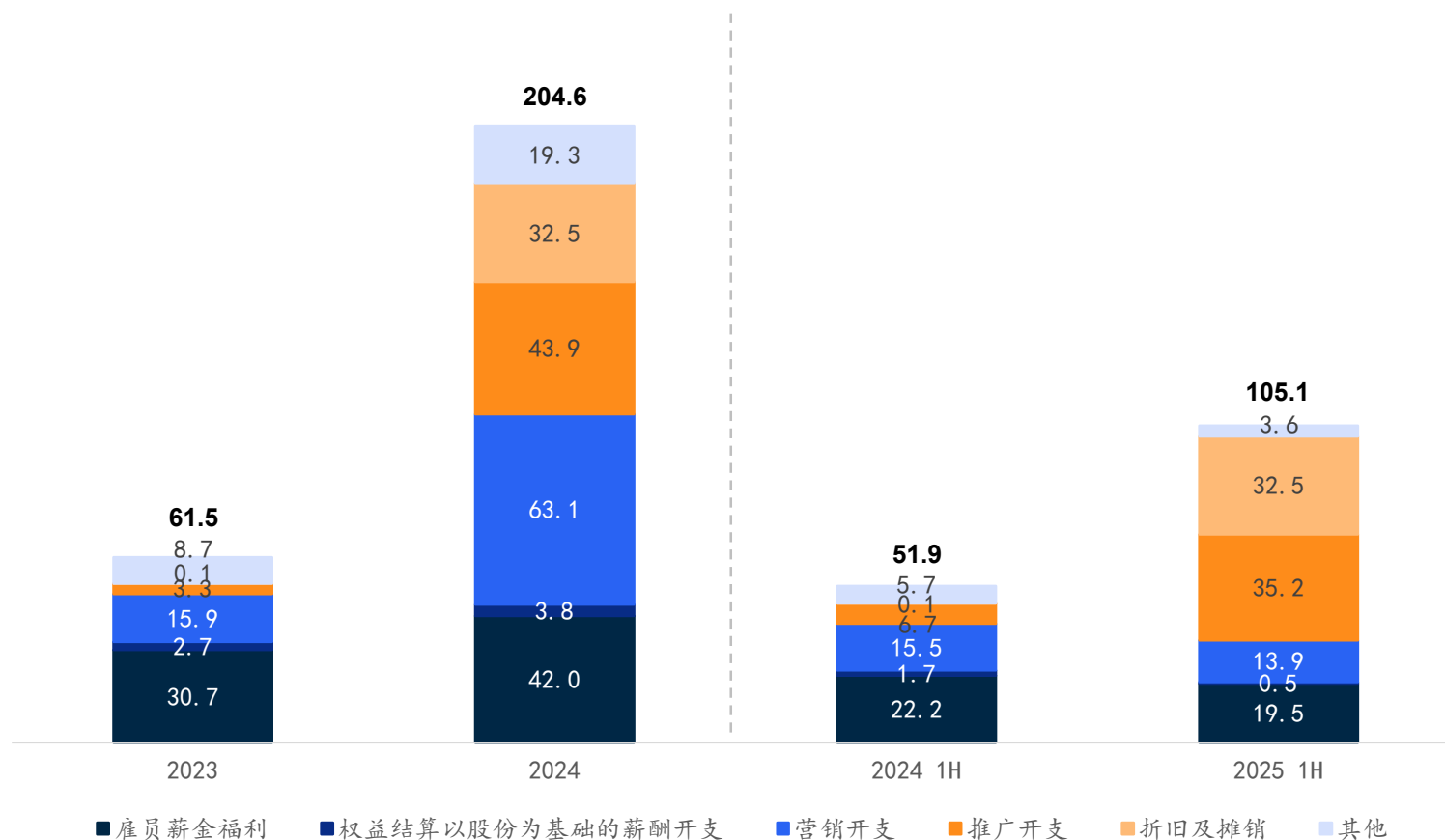
■ 往绩记录期内，公司的营运开支包括销售及营销开支、研发投入、行政开支、融资成本等

■ 展望未来，随着我们持续推进及扩展管线并逐步将产品管线商业化，预期营运开支亦将相应增加，并在规模经济优势带动下持续提升成本效益

2023–2025上半年销售费用构成

销售费用分析

(人民币百万元)



- 销售及营销开支主要包括：(i)销售人员的雇员薪金及福利；(ii)权益结算以股份为基础的薪酬开支；(iii)学术活动、医生教育和其他营销活动的营销开支；(iv)推广开支，主要为福可苏®的推广活动；(v)用于销售及营销目的之物业、厂房及设备以及无形资产的折旧及摊销开支。具体而言，我们就2024年与信达订立之资产购买协议所涉及之商业化权利予以资本化，并随后摊销为销售及营销开支；及(vi)其他开支，主要包括差旅及交通开支以及其他杂项开支。

资产负债表

(人民币千元)	于12月31日		于6月30日
	2023年	2024年	2025年 (未经审核)
非流动资产			
物业、厂房及设备	99,764	67,464	84,075
使用权资产	218,350	207,871	197,479
其他无形资产	6,417	854,685	849,833
于联营公司之投资	—	1,935	—
定期存款	183,824	177,288	179,613
其他非流动资产	3,098	7,009	3,190
非流动资产总额	511,453	1,316,252	1,314,190
流动资产			
存货	25,776	33,369	43,340
贸易应收款项	1,046	2,972	846
预付款项、其他应收款项及其他资产	44,812	97,848	116,303
按公允价值计入损益之金融资产	50,225	—	—
受限制现金	1,949	2,045	2,045
定期存款	121,755	190,652	337,664
现金及现金等价物	179,163	57,626	53,039
流动资产总额	424,726	384,512	553,237
资产总值	936,179	1,700,764	1,867,427

资产负债表（续）

(人民币千元)	于12月31日		于6月30日
	2023年	2024年	2025年 (未经审核)
流动负债			
贸易应付款项	24,826	26,686	32,766
其他应付款项及应计费用	31,577	40,053	37,463
合约负债	21,549	28,584	29,072
计息银行借款	54,532	45,170	67,214
租赁负债	4,761	17,990	17,051
流动负债总额	137,245	158,483	183,566
流动资产净额	287,481	226,029	369,671
总资产减流动负债	798,934	1,542,281	1,683,861
非流动负债			
计息银行借款	206,050	377,880	685,195
租赁负债	238,833	240,514	237,827
递延收入	3,659	2,768	2,266
非流动负债总额	448,542	621,162	925,288
资产净值	350,392	921,119	758,573
股本	373,372	455,332	455,332
(累计亏损)/储备	(22,980)	465,787	303,241
总权益	350,392	921,119	758,573

现金流量表



(人民币千元)	截至12月31日止年度		截至6月30日止六个月	
	2023年	2024年	2024年 (未经审核)	2025年 (未经审核)
经营活动所得现金流量				
除税前亏损	(424,023)	(403,238)	(138,720)	(196,390)
就下列各项作出调整：				
融资成本	13,766	23,039	11,221	15,559
银行利息收入	(12,996)	(16,494)	(9,099)	(9,112)
来自按公允价值计入损益之金融资产之其他投资收入	(2,365)	(476)	(357)	—
出售一间联营公司的收益	—	—	—	(65)
物业、厂房及设备折旧	39,717	38,569	22,554	33,548
使用权资产折旧	14,318	20,353	10,003	10,392
无形资产摊销	2,758	35,325	1,433	33,897
出售物业、厂房及设备亏损	58	10	8	11
应占联营公司亏损	—	65	—	—
按公允价值计入损益之金融资产公允价值收益	(225)	—	—	—
以权益结算以股份为基础之薪酬开支	106,235	73,853	44,362	33,832
存货增加	(16,279)	(7,593)	(10,211)	(9,971)
预付款项-其他应收款项及其他资产减少/(增加)	21,850	(53,036)	(19,053)	(18,455)
贸易应收款项（增加）/ 减少	(1,046)	(1,926)	300	2,126
贸易应付款项（减少） / 增加	(9,982)	1,860	10,659	6,080
合约负债增加	21,549	7,035	4,778	488
递延收入减少	(838)	(891)	(427)	(502)
其他应付款项及应计费用增加 / (减少)	(8,102)	8,991	(1,901)	725
经营活动所用现金	(255,605)	(274,554)	(74,450)	(97,837)
已收利息	2,871	2,507	1,164	277
已付所得税	(439)	—	—	—
经营活动所用现金流量净额	(253,173)	(272,047)	(73,286)	(97,560)

资料来源：公司招股书

现金流量表（续）

(人民币千元)	截至12月31日止年度		截至6月30日止六个月	
	2023年	2024年	2024年 (未经审核)	2025年 (未经审核)
投资活动所得现金流量				
购买物业、厂房及设备项目	(21,913)	(10,792)	(5,531)	(48,095)
出售物业、厂房及设备以及其他无形资产项目所得款项	278	108	72	839
购买其他无形资产	(987)	(883,594)	(7,004)	(29,045)
购买按公允价值计入损益之金融资产	(955,000)	(340,000)	(240,000)	—
收购时原到期日超过三个月的银行存款增加	(550,368)	(207,846)	(96,252)	(208,647)
按公允价值计入损益之金融资产所得款项	907,365	390,701	290,582	—
提取收购时原到期日超过三个月的银行存款	254,915	159,471	17,593	68,145
出售联营公司之所得款项	—	—	—	2,000
收购联营公司的股权	—	(2,000)	—	—
投资活动所用现金流量净额	(365,710)	(893,952)	(40,540)	(214,803)
融资活动所得现金流量				
股东注资所得款项净额	418,779	900,000	—	—
新银行贷款	232,000	337,300	252,765	569,740
银行贷款的还款	(128,981)	(182,350)	(146,808)	(240,855)
租赁付款的本金部分	(2,202)	(7,547)	(2,933)	(9,906)
受限制现金增加	(21)	(97)	—	—
已付利息	(15,036)	(2,938)	(4,537)	(8,805)
上市开支付款	—	—	—	(2,295)
融资活动所得现金流量净额	504,539	1,044,368	98,487	307,879
现金及现金等价物增加净额	(114,344)	(121,631)	(15,339)	(4,484)
年 / 期初现金及现金等价物	293,371	179,163	179,163	57,626
汇率变动影响净额	136	94	270	(103)
年 / 期末现金及现金等价物	179,163	57,626	164,094	53,039

损益表

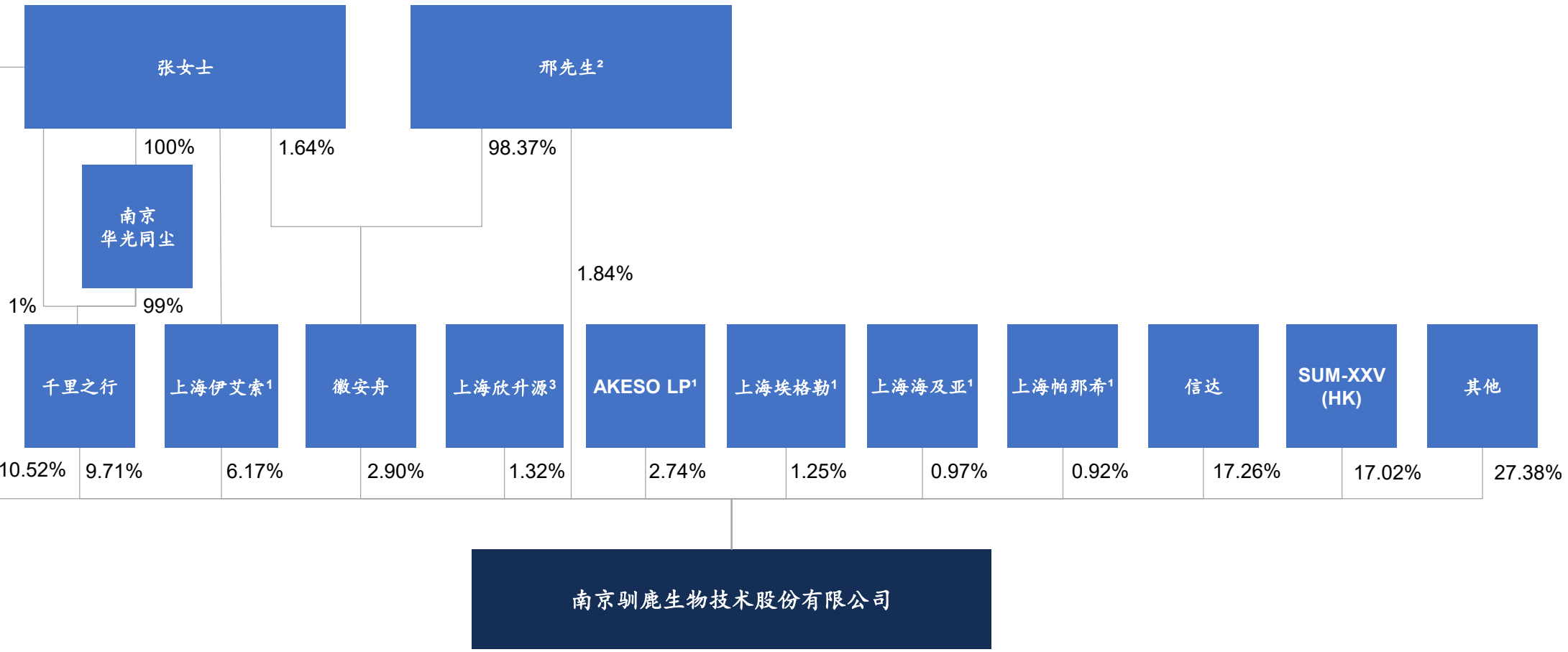
(人民币千元)	截至12月31日止年度		截至6月30日止六个月	
	2023年	2024年	2024年 (未经审核)	2025年 (未经审核)
收入	44,786	207,478	93,394	90,957
销售成本	(19,949)	(66,478)	(26,946)	(29,237)
毛利	24,837	141,000	66,448	61,720
其他收入及收益	29,885	56,778	21,403	15,710
销售及营销开支	(61,485)	(204,621)	(51,877)	(105,138)
行政开支	(168,482)	(152,931)	(74,034)	(69,459)
研发成本	(234,034)	(213,199)	(86,895)	(79,703)
其他开支	(978)	(7,161)	(2,544)	(3,961)
融资成本	(13,766)	(23,039)	(11,221)	(15,559)
分占联营公司亏损	—	(65)	—	—
除税前亏损	(424,023)	(403,238)	(138,720)	(196,390)
所得税开支	(439)	—	—	—
年/期内公司拥有人应占亏损	(424,462)	(403,238)	(138,720)	(196,390)
公司普通股股权持有人应占每股亏损 (人民币)	-1.14	-0.97	-0.37	-0.43



附录 B

股权结构

股权结构图





附录 C

市场数据

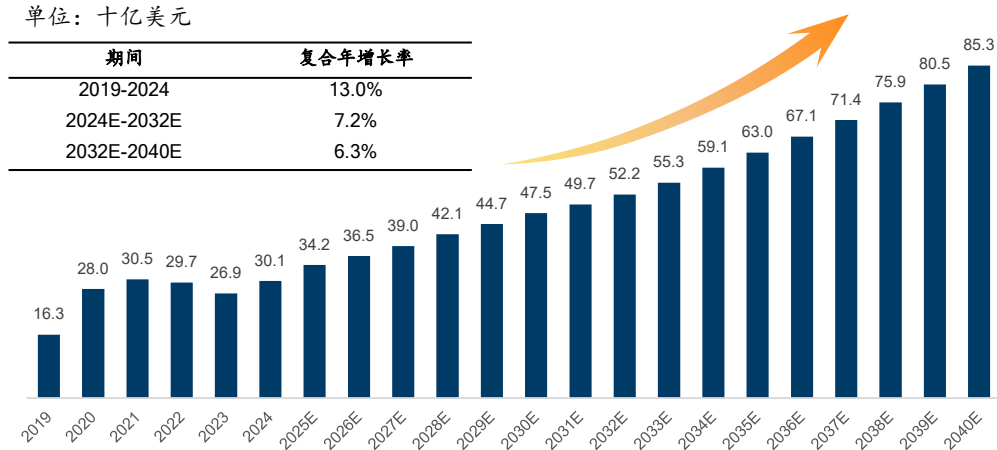
多发性骨髓瘤(MM)行业概览

MM为一种生于骨髓中浆细胞的癌症。浆细胞是负责产生抗体的白血球，在免疫系统中发挥关键作用。当健康浆细胞转化为恶性细胞并不受控制地增殖时，即会发展为MM。该疾病常导致显著的骨骼损伤，包括溶骨性病灶、骨质疏松及病理性骨折

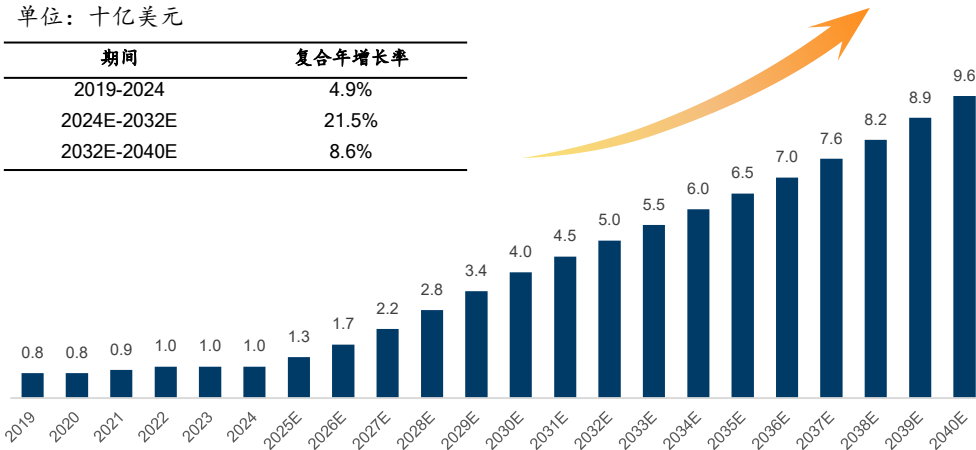


- 全球MM的发病数由2019年的16.43万宗上升至2024年的19.72万宗，预计于2040年将达到**27.36万宗**。中国MM发病数由2019年的2.81万宗上升至2024年的3.18万宗，并预计于2040年将达到**4.4万宗**
- 以浆细胞相关抗原为靶点的CAR-T细胞疗法，如**BCMA**，已成为治疗MM的重要方针。**GPRC5D**近期成为具潜力的替代靶点，其表达独立于BCMA，且高度富集于恶性浆细胞，显示出良好的治疗指数

2019年至2040年（预测）全球MM药物市场



2019年至2040年（预测）中国MM药物市场



CAR-T细胞疗法已改变MM的治疗格局，但仍存在关键且未满足需求。
尽管CAR-T细胞疗法已在全球多个国家和地区获得批准，但在新加坡、泰国及欧洲许多国家等主要市场之外，其可用性和可及性仍然受限

多发性骨髓瘤(MM)竞争格局



通用名称	品牌名称	靶点	公司	首次批准日期	全人源化	获批地区	中国市场份额
Eqeucabtagene autoleucel (伊基奥仑赛注射液)	Fucaso® 福可苏®	BCMA	本公司	2023年6月30日	是	中国内地、澳门	67.7%
Zevorcabtagene autoleucel (泽沃基奥仑赛注射液)	赛恺泽®	BCMA	科济药业	2024年2月23日	是	中国内地	32.3%
Idecabtagene vicleucel	Abecma®	BCMA	BMS	2021年3月3日	否	欧盟、日本、美国、英国、 瑞士、以色列	/
Ciltacabtagene autoleucel (西达基奥仑赛注射液)	Carvykti®	BCMA	强生/传奇生物	2022年2月28日 (美国)	否	美国、欧盟、英国、中国内地、 韩国、加拿大、日本、巴西、 澳大利亚	/
	卡卫获®			2024年8月20日 (中国内地)			

附注：截至最后实际可行日期，卡卫获®于中国已获批但尚未推出；市场份额根据公司有效订单数量计算。

品牌	福可苏®		Abecma®	Carvykti®	赛恺泽®
	未接受CAR-T细胞疗法患者 N=97	所有患者 N=109	N=128	N=97	N=102
批准	中国 2023年6月		美国 2021年3月	美国 2022年2月	中国 2024年2月
总缓解率	98.9%*	96.3%**	73%	97.9%	92.2%
≥完全缓解率	88.4%*	83.2%**	33%	82.5%	71.6%
mPFS (月)	35.9	30.5	8.8	34.9	/
≥3级CRS	1.0%	0.9%	5.5%	5.1%	6.9%
≥3级ICANS	0%		/	2.1%	0%
帕金森综合征	0%		/	5%	0%
第二原发性恶性肿瘤	0%		7%	6%	0%
≥3级CAR-T相关神经毒性 (包括ICANS)	0%		4%	11%	0%

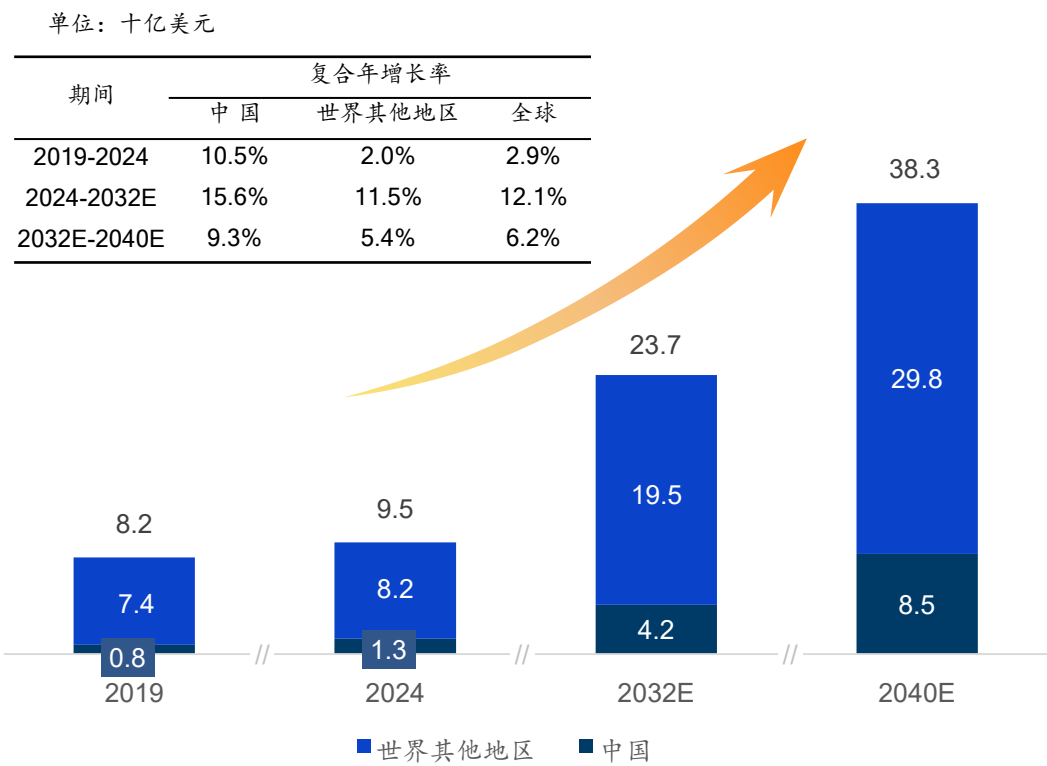
*截至数据截止日期2024年12月31日，数据来自95名可评估疗效的患者。
**截至数据截止日期2024年12月31日，数据来自107名可评估疗效的患者。

- 在全球已获批准的CAR-T细胞疗法中，根据截至2024年12月31日的最新数据，在未接受过CAR-T疗法的患者中，福可苏®显示出最高的总缓解率（98.9%）和CR/sCR（88.4%）
- 安全性方面，福可苏®的重度细胞因子释放综合征发生率最低，且未报告重度神经毒性病例，凸显卓越的安全特性，较同类产品更胜一筹

非霍奇金淋巴瘤（NHL）市场概览

NHL 约占所有淋巴瘤的90%，涵盖多种子集，侵袭性B细胞淋巴瘤属于NHL的一个子集，其生长迅速，需要及时强效的治疗，其中最常见的子集为弥漫大B细胞淋巴瘤（DLBCL）

过往及预期全球DLBCL药物市场规模，2019年至2040年（预期）



DLBCL的CAR-T细胞疗法竞争格局

- ✓ 全球已批准六种针对DLBCL的CAR-T细胞疗法,所有产品均仅针对CD19
- ✓ IASO120是中国临床进度最快的针对 DLBCL的双特异性CAR-T细胞疗法

药品名称	靶点	临床阶段	适应症	公司	首次公开日期	地区
Rondecabtagene autoleucel	CD19/CD20	III期	DLBCL	ImmPACT Bio	2025年9月23日	/
Zamtocabtagene autoleucel	CD19/CD20	II期	DLBCL	Miltenyi Biomedicine	2021年3月9日	全球
IASO120	CD19/CD22	I/II期	DLBCL	本公司	2021年9月15日	中国
AVC-203	CD19/CD20	I/II期	DLBCL	AvenCell	2025年10月27日	欧盟
EB BH2024	CD19/CD22	I/II期	DLBCL	埃森生物	2024年1月19日	中国
HY004	CD19/CD22	I/II期	DLBCL	合源生物	2023年8月30日	中国
EXP039	CD19/CD20	I/II期	DLBCL	AbelZeta	2022年6月16日	全球

DLBCL的治疗仍有庞大的未满足医疗需求，尽管CAR-T细胞疗法已被认定为突破性治疗，并纳入二线及三线治疗模式，其长期疗效仍然有限，凸显对更安全、更耐受的治疗方法的迫切需求



附录 D

临床数据

Eque-cel – 同类首创与潜在最佳的BCMA CAR-T疗法（续）



临床数据概要

于r/r MM患者中的Ib/II期关键临床试验 (FUMANBA-1)

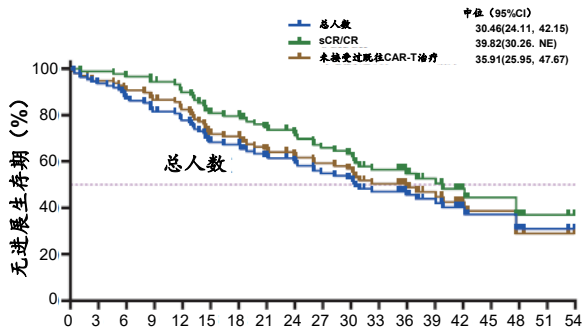
疗效特征

安全性特征

- 在107名可评估疗效的患者中，观察到96.3%的ORR，其中83.2%患者达到≥CR。中位DOR和中位PFS分别为31.3个月和30.5个月。对于未接受过既往CAR-T细胞疗法的患者（N=95），ORR为98.9%，中位PFS达到35.9个月
- 总体MRD阴性率为95.3%。于达到CR或更佳疗效(≥CR, N=89)的患者中，MRD阴性率达100%。未曾接受过既往CAR-T细胞疗法的患者MRD阴性率为98.9%；达到≥CR的患者和未曾接受既往CAR-T细胞疗法的患者，MRD阴性时间的中位数均为36.5个月

- 109名接受治疗患者中有93.6%出现CRS，但大部分（92.7%）为1至2级，只有1名患者（0.9%）出现3级CRS。
- CRS的中位发病时间为6天，中位持续时间为5天。ICANS较罕见，仅影响2名患者（1.8%），两者均为1至2级

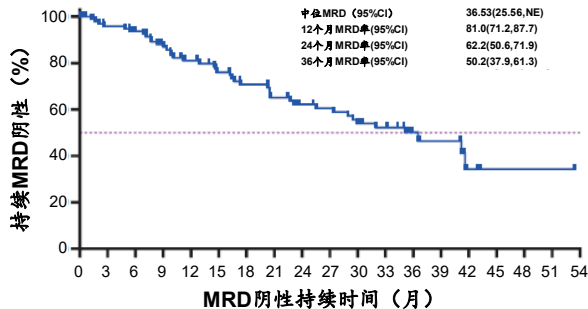
PFS Kaplan-Meier 曲线



风险数量

总人数	109	102	94	88	82	72	70	60	57	51	48	40	31	24	13	6	4	2	0
sCR/CR	89	88	86	84	79	71	69	60	57	51	48	40	31	24	13	6	4	2	0
未接受过既往CAR-T治疗	97	92	88	84	78	68	66	56	53	49	46	38	29	22	11	4	3	2	0

MRD Kaplan-Meier 曲线



风险数量

总人数	109	102	94	88	82	72	70	60	57	51	48	40	31	24	13	6	4	2	0
-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---

MRD Kaplan-Meier 曲线

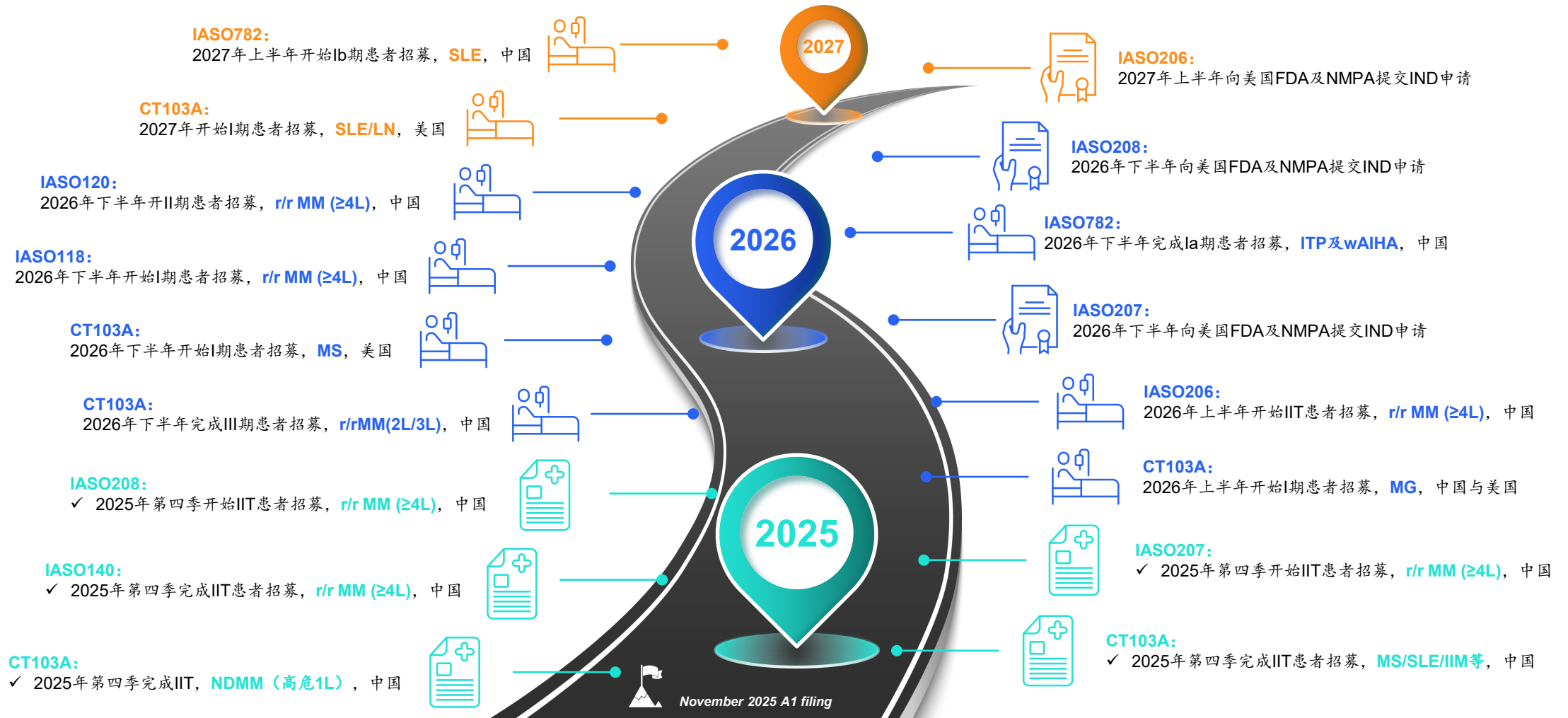
N=109	CRS	ICANS
任何级别, n(%)	102 (93.6)	2 (1.8)
1级	74 (67.9)	1 (0.9)
2级	27 (67.9)	1 (0.9)
3级	27 (24.8)	0
首次发病时间, 天数, 中位数 (范围)	6 (1, 13)	6.5 (3, 10)
持续时间, 天数, 中位数 (范围)	5 (2, 30)	1.5 (1, 2)



附录 E

潜在里程碑

后续预期产品管线里程碑





谢谢